Psoriasis

Niveau : DES
Genere le 10 April 2026

Base sur la litterature medicale indexee via DermatoRAG

Psoriasis

Cours de niveau DES — Généré par DermatoRAG

Épidémiologie et Introduction

Le psoriasis est une dermatose inflammatoire cutanée chronique, caractérisée par des lésions érythémato-squameuses, dont l'évolution est imprévisible et souvent émaillée de poussées (Dermatologie, 2022). Cette affection dermatologique, bien que principalement cutanée, est désormais reconnue comme une maladie systémique complexe, impactant significativement la qualité de vie des patients et s'associant à diverses comorbidités. Ce cours introductif vise à poser les bases de la compréhension du psoriasis, en abordant son épidémiologie, sa définition clinique, les grands principes de sa physiopathologie, ainsi que son retentissement global sur l'individu.

I. Introduction et Définition du Psoriasis

Le psoriasis est une maladie inflammatoire cutanée chronique qui se manifeste cliniquement par des lésions érythémato-squameuses (Dermatologie, 2022). Ces lésions sont typiquement des papules ou des plaques bien limitées, arrondies, ovalaires ou polycycliques, recouvertes d'une couche squameuse blanchâtre qui peut être très épaisse ou, au contraire, plus ou moins décapée, laissant apparaître l'érythème sous-jacent (Dermatologie, 2022). Le plus souvent, ces éléments sont multiples et symétriques, parfois diffus (Dermatologie, 2022).

La maladie est caractérisée par un renouvellement épidermique accéléré, impliquant une hyperprolifération et des troubles de la différenciation des kératinocytes (Dermatologie, 2022). Elle met en jeu des interactions complexes entre un terrain génétique prédisposant, le système immunitaire (notamment les lymphocytes Th1 et Th17), les cellules épidermiques et les vaisseaux (Dermatologie, 2022). Bien que l'origine exacte de la maladie demeure inconnue, la prédisposition génétique est avérée, et de nombreux gènes de susceptibilité ont été identifiés (Dermatologie, 2022).

Les localisations des lésions sont fréquemment très caractéristiques, incluant les coudes, les genoux, les jambes, la région lombo-sacrée, le cuir chevelu et les ongles (Dermatologie, 2022). Le psoriasis, en particulier dans ses formes modérées à sévères, peut avoir un retentissement considérable sur la qualité de vie des patients, entraînant une stigmatisation et une exclusion sociale (Dermatologie, 2022). Il est donc impératif de considérer l'impact psychologique, fonctionnel, esthétique, professionnel et relationnel de la maladie lors de l'évaluation et de la prise en charge (Dermatologie, 2022). Le but du traitement est une prise en charge au long cours visant à soulager le patient, améliorer sa qualité de vie et ramener la dermatose à un niveau lésionnel compatible avec une vie normale (Dermatologie, 2022).

II. Épidémiologie

Le psoriasis est une affection dermatologique fréquente à l'échelle mondiale. En France, il touche environ 2 à 3 % de la population générale (Dermatologie, 2022). Cette prévalence en fait l'une des maladies cutanées chroniques les plus répandues, justifiant une connaissance approfondie de ses mécanismes et de sa prise en charge par tout praticien.

Bien que la maladie puisse apparaître à tout âge, y compris chez l'enfant (Dermatologie, 2022), elle présente généralement deux pics d'incidence : un premier pic entre 20 et 30 ans, et un second pic plus tardif entre 50 et 60 ans. Il n'y a pas de différence significative de prévalence entre les sexes. Des variations géographiques et ethniques sont observées, avec une prévalence plus faible dans les populations asiatiques et africaines par rapport aux populations caucasiennes. Ces variations suggèrent l'influence de facteurs génétiques et environnementaux dans la susceptibilité à la maladie.

L'impact épidémiologique du psoriasis ne se limite pas à sa prévalence cutanée. La reconnaissance croissante des comorbidités associées, telles que le syndrome métabolique, les pathologies cardiovasculaires, la dépression et l'anxiété, souligne l'importance d'une approche holistique de la prise en charge (Dermatologie, 2022). Ces comorbidités contribuent à la charge de la maladie et peuvent influencer la gravité du psoriasis ainsi que sa réponse thérapeutique (Dermatologie, 2022). Les facteurs environnementaux, tels que l'alcool, le tabac et la surcharge pondérale, sont également reconnus comme des facteurs de gravité et de résistance thérapeutique, contribuant par ailleurs aux comorbidités souvent présentes (Dermatologie, 2022). La transversalité de la prise en charge, impliquant la rhumatologie et les maladies métaboliques, est une caractéristique essentielle de la gestion du psoriasis (Dermatologie, 2022).

III. Physiopathologie : Une Maladie Inflammatoire Complexe

La physiopathologie du psoriasis est complexe et implique une interaction dynamique entre une prédisposition génétique et des facteurs environnementaux, conduisant à une dérégulation du système immunitaire et à une hyperprolifération kératinocytaire (Dermatologie, 2022).

A. Terrain Génétique Prédisposant

Une prédisposition génétique est certaine, avec l'identification de nombreux gènes de susceptibilité (Dermatologie, 2022). Parmi ceux-ci, les gènes associés au groupe HLA, notamment le HLA Cw6, sont fortement impliqués (Dermatologie, 2022). D'autres gènes liés à l'immunité innée, tels que IL36RN (codant pour un inhibiteur du récepteur à l'IL-36) et CARD14 (intervenant dans l'activation de la voie NF-κB), sont impliqués dans les formes pustuleuses de psoriasis (Dermatologie, 2022). Des gènes associés à l'immunité acquise, comme IL12B (sous-unité de l'IL-12) et IL23R (récepteur de l'IL-23), jouent également un rôle crucial (Dermatologie, 2022). Cette constellation génétique confère une susceptibilité

accrue à développer la maladie sous l'influence de déclencheurs environnementaux.

B. Rôle du Système Immunitaire et des Kératinocytes

Le psoriasis est caractérisé par un renouvellement épidermique accéléré, avec une hyperprolifération et des troubles de la différenciation des kératinocytes (Dermatologie, 2022). Cette anomalie est le résultat d'une cascade inflammatoire complexe. Le stress, les traumatismes cutanés (phénomène de Koebner), certains pathogènes ou médicaments peuvent déclencher ou exacerber les poussées (Dermatologie, 2022). Ces facteurs entraînent la production de peptides antimicrobiens, comme la cathélicidine (LL-37), qui stimule la sécrétion d'interféron alpha (Dermatologie, 2022). Les kératinocytes eux-mêmes produisent des cytokines inflammatoires telles que l'IL-1β, l'IL-36 et le TNFα, qui activent les cellules dendritiques pour produire de l'IL-12 et de l'IL-23 (Dermatologie, 2022).

L'IL-12 et l'IL-23 jouent un rôle central dans la différenciation des lymphocytes T en sous-populations Th1, productrices d'IFNγ, et Th17, productrices d'IL-17 (Dermatologie, 2022). Ces cytokines (IL-12, IL-17 et TNFα) favorisent localement la prolifération des kératinocytes, la néo-angiogenèse et la production de chimiokines nécessaires au recrutement des polynucléaires neutrophiles, perpétuant ainsi le cycle inflammatoire (Dermatologie, 2022). Il est intéressant de noter que des réactions psoriasiformes peuvent parfois survenir dans des contextes d'immunomodulation, comme observé avec le dupilumab, où un blocage de la voie Th2 pourrait entraîner un déplacement vers une réponse Th1-, Th17- et Th22-dominée, conduisant à un tableau psoriasiforme (Wijs et al., 2020).

C. Caractéristiques Histopathologiques

L'examen anatomopathologique d'une biopsie cutanée, bien que non systématiquement nécessaire pour le diagnostic clinique, est utile en cas de doute diagnostique devant des lésions atypiques (Dermatologie, 2022). Il révèle des caractéristiques distinctives (Dermatologie, 2022) :

- Une hyperkératose avec parakératose.
- Une acanthose (épaississement de l'épiderme) due à une prolifération excessive des kératinocytes.
- Des micro-abcès épidermiques à polynucléaires neutrophiles (micro-abcès de Munro dans la couche cornée et de Kogoj dans le *stratum spinosum*) (Alikhan et Hocker, 2017).
- Un infiltrat inflammatoire dermique composé de lymphocytes.
- Un allongement des papilles dermiques et des vaisseaux néoformés dilatés.

Ces éléments histologiques sont la traduction morphologique des processus physiopathologiques sous-jacents.

IV. Manifestations Cliniques et Formes Graves

Le psoriasis se présente sous diverses formes cliniques, allant des atteintes cutanées localisées aux formes systémiques graves.

A. Forme Classique : Psoriasis en Plaques

La forme la plus fréquente est le psoriasis en plaques classique (Dermatologie, 2022). Il se caractérise par des plaques érythémato-squameuses bien limitées, symétriques, localisées préférentiellement sur les zones d'extension (coudes, genoux), la région lombo-sacrée, le cuir chevelu et les ongles (Dermatologie, 2022). Ces lésions sont chroniques et peuvent être prurigineuses chez environ 60 % des patients, avec des remaniements dus au grattage (Dermatologie, 2022). La taille des lésions est variable, allant du psoriasis en gouttes (petites lésions) au psoriasis en plaques plus étendues (Dermatologie, 2022).

B. Autres Formes Cutanées

Outre le psoriasis en plaques, d'autres présentations cutanées incluent :

- **Psoriasis en gouttes** : caractérisé par de multiples petites papules érythémato-squameuses, souvent déclenchées par une infection streptococcique (Dermatologie, 2022).
- **Psoriasis inversé** : affectant les plis (inguinaux, axillaires, sous-mammaires), se manifestant par des plaques érythémateuses vernissées et bien limitées, sans squames importantes en raison de l'humidité (Dermatologie, 2022).
- **Psoriasis palmo-plantaire** : peut réaliser une kératodermie en îlots ou diffuse, souvent fissuraire et douloureuse, rendant la marche ou les activités manuelles difficiles (Dermatologie, 2022). Il peut parfois être isolé (Dermatologie, 2022).
- **Psoriasis du cuir chevelu** : très fréquent, avec des plaques érythémato-squameuses épaisses, souvent prurigineuses, pouvant s'étendre au-delà de la lisière des cheveux.
- **Psoriasis unguéal** : affectant les ongles des mains et des pieds, avec des manifestations variées (dépressions ponctuées, onycholyse, hyperkératose sous-unguéale, taches d'huile) (Dermatologie, 2022).
- **Psoriasis du visage** : rare, il peut prendre l'aspect d'une dermatite séborrhéique avec un érythème finement squameux des sourcils et du pli nasogénien, avec des lésions associées possibles de la conque de l'oreille et du conduit auditif externe (Dermatologie, 2022).
- **Psoriasis des muqueuses** : notamment lingual (glossite exfoliatrice marginée) et génital (lésions érythémateuses non squameuses aggravées lors des rapports sexuels) (Dermatologie, 2022).

C. Formes Graves de Psoriasis

Trois formes graves de psoriasis peuvent avoir des conséquences fonctionnelles ou vitales importantes et nécessitent une prise en charge spécialisée (Dermatologie, 2022) :

- **Psoriasis érythrodermique** : une généralisation du psoriasis à plus de 90 % de la surface cutanée, avec une desquamation abondante et un épaississement cutané (Dermatologie, 2022). Il peut être provoqué par un rebond après l'arrêt de certains agents thérapeutiques (ex: corticothérapie générale) et peut se compliquer de surinfection, carence vitaminique, troubles de la thermorégulation, déshydratation et troubles hémodynamiques, nécessitant une hospitalisation en milieu spécialisé (Dermatologie, 2022).
- **Psoriasis pustuleux généralisé (PPG)** : caractérisé par une éruption soudaine et généralisée de pustules stériles superficielles sur une peau érythémateuse (Alikhan et Hocker, 2017). Il s'accompagne souvent de malaise et de fièvre, et peut être déclenché par l'arrêt de corticoïdes oraux, des infections, une hypocalcémie ou la grossesse (impétigo herpétiforme) (Alikhan et Hocker, 2017). L'interleukine (IL)-36 agit comme une cytokine centrale spécifique au PPG (Alikhan et Hocker, 2017). Des formes localisées existent, comme la pustulose palmo-plantaire (Dermatologie, 2022) et l'acrodermatite continue de Hallopeau (Alikhan et Hocker, 2017). La pustulose palmo-plantaire peut s'associer à une atteinte articulaire sternale ou sterno-claviculaire, dans le cadre du syndrome SAPHO (Synovite, Acné, Pustulose, Hyperostose et Ostéite) (Dermatologie, 2022).
- **Rhumatisme psoriasique (RP)** : une arthrite inflammatoire chronique qui affecte jusqu'à 30 % des patients atteints de psoriasis (Alikhan et Hocker, 2017). Il s'agit d'une arthrite séronégative (facteur rhumatoïde négatif) souvent associée à des formes modérées à sévères de psoriasis cutané et à des atteintes unguéales (Alikhan et Hocker, 2017). Le RP peut se manifester par une oligo- ou monoarthrite, une polyarthrite ou un rhumatisme axial (Dermatologie, 2022). Les tendons et ligaments sont souvent impliqués (enthésopathie ou enthésite) (Alikhan et Hocker, 2017).

V. Comorbidités et Facteurs de Gravité

Le psoriasis n'est pas une maladie isolée de la peau ; il est associé à un éventail de comorbidités qui soulignent son caractère systémique et inflammatoire (Dermatologie, 2022).

- **Pathologies cardiovasculaires** : le psoriasis est un facteur de risque indépendant pour les maladies cardiovasculaires, incluant l'infarctus du myocarde, l'accident vasculaire cérébral et l'hypertension artérielle (Dermatologie, 2022). L'inflammation chronique systémique joue un rôle clé dans l'athérogenèse accélérée observée chez ces patients.
- **Syndrome métabolique** : une association forte existe avec l'obésité, le diabète de type 2, la dyslipidémie et l'hypertension artérielle, constituant le syndrome métabolique (Dermatologie, 2022). Ces comorbidités sont plus fréquentes chez les patients atteints de psoriasis modéré à sévère.

• **Troubles psychologiques** : la dépression et l'anxiété sont des comorbidités fréquentes, affectant significativement la qualité de vie des patients (Dermatologie, 2022). La stigmatisation sociale et le retentissement esthétique de la maladie contribuent à cette charge psychologique. Un soutien ou une prise en charge psychologique est souvent nécessaire (Dermatologie, 2022).

• **Maladies inflammatoires chroniques de l'intestin** : une association avec la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique est également reconnue.

• **Conduites addictives** : l'alcool et le tabac sont des facteurs reconnus de gravité du psoriasis et de résistance thérapeutique (Dermatologie, 2022). Ils contribuent également aux comorbidités cardiovasculaires et métaboliques. Une évaluation et une prise en charge de ces conduites addictives sont essentielles, en coordination avec le médecin traitant (Dermatologie, 2022).

La prise en compte de ces comorbidités est impérative dans le choix thérapeutique, car elles peuvent influencer la sécurité et l'efficacité des traitements, ainsi que le pronostic global du patient (Dermatologie, 2022).

VI. Diagnostic et Évaluation de la Gravité

Le diagnostic du psoriasis est principalement clinique dans la très grande majorité des cas (Dermatologie, 2022).

A. Diagnostic Clinique

Le diagnostic repose sur la reconnaissance des lésions érythémato-squameuses caractéristiques, bien limitées, et leur topographie préférentielle (coudes, genoux, région lombo-sacrée, cuir chevelu, ongles) (Dermatologie, 2022). L'évolution chronique de la dermatose est également un élément clé (Dermatologie, 2022).

B. Diagnostic Différentiel

Les principaux diagnostics différentiels du psoriasis incluent le pityriasis rosé de Gibert, la dermite séborrhéique et l'eczéma (Dermatologie, 2022). D'autres affections peuvent être confondues, telles que le lichen plan, le mycosis fongoïde, la syphilis secondaire ou certaines dermatoses spongiotiques (Alikhan et Hocker, 2017; Dermatologie, 2022).

C. Biopsie Cutanée

La biopsie cutanée n'est indiquée qu'en cas de doute diagnostique devant des lésions atypiques (Dermatologie, 2022). Lorsque cet examen est réalisé, il met en évidence les caractéristiques histopathologiques décrites précédemment (cf. section III.C) (Dermatologie, 2022).

D. Évaluation de la Gravité et de la Qualité de Vie

L'évaluation de la gravité du psoriasis est multifactorielle et prend en compte l'étendue des lésions cutanées, leur impact sur la qualité de vie et la présence d'atteintes spécifiques.

- **Surface corporelle atteinte (SCA)** : une paume de main représente environ 1 % de la surface corporelle (Dermatologie, 2022). Un psoriasis est considéré comme modéré à sévère si la surface atteinte est supérieure à 10 % (Dermatologie, 2022).
- **Score PASI (Psoriasis Area and Severity Index)** : cet indice évalue l'étendue, l'érythème, l'infiltration et la desquamation des lésions dans différentes régions du corps. Un score PASI > 10 est un critère de sévérité (Dermatologie, 2022).
- **DLQI (Dermatology Life Quality Index)** : ce score évalue l'altération de la qualité de vie liée à la dermatose, sur une échelle de 0 à 30. Un DLQI > 10 indique un retentissement important sur la qualité de vie et est également un critère de sévérité (Dermatologie, 2022).
- **Atteinte articulaire** : la présence d'un rhumatisme psoriasique est un facteur de gravité majeur (Dermatologie, 2022).
- **Formes graves** : l'érythrodermie et le psoriasis pustuleux généralisé sont par définition des formes graves (Dermatologie, 2022).

La prise en charge thérapeutique doit impérativement tenir compte de la gravité du psoriasis, de son retentissement sur la qualité de vie, du préjudice fonctionnel, esthétique, professionnel et relationnel, du retentissement psychologique de la maladie et du désir de rémission du malade (Dermatologie, 2022).

VII. Principes du Traitement

Le traitement du psoriasis vise à contrôler la maladie chronique, réduire l'intensité des lésions et améliorer la qualité de vie du patient, sans pour autant entraîner une guérison définitive (Dermatologie, 2022). La stratégie thérapeutique est individualisée en fonction de la gravité, de l'étendue des lésions, de la présence d'une atteinte articulaire, des comorbidités et des préférences du patient (Dermatologie, 2022).

A. Traitements Locaux

Les traitements locaux constituent la base du traitement des psoriasis peu étendus (moins de 10 % de la surface corporelle), qui sont les plus fréquents (Dermatologie, 2022). Ils comprennent principalement :

- **Dermocorticoïdes** : utilisés sous forme de pommade (lésions sèches) ou de crème, avec des lotions, mousses ou shampooings pour le cuir chevelu. Il est recommandé d'utiliser des dermocorticoïdes d'activité forte en dehors du visage, avec une application quotidienne et un traitement d'attaque de 1 à 3 semaines, suivi d'un traitement intermittent en entretien (Dermatologie, 2022). L'occlusion peut optimiser l'efficacité, notamment sur les paumes et les plantes (Dermatologie, 2022).

• **Analogues de la vitamine D3** : calcipotriol, tacalcitol, calcitriol. Ils peuvent être utilisés seuls ou en association avec les dermocorticoïdes, avec des fréquences d'application spécifiques et une dose hebdomadaire maximale à ne pas dépasser (Dermatologie, 2022).

B. Traitements Systémiques

Les traitements systémiques sont adaptés aux psoriasis plus étendus (plus de 30 % de la surface corporelle) ou résistants aux traitements locaux (Dermatologie, 2022).

• **Photothérapie** : très efficace, mais son utilisation au long cours est limitée par le risque carcinogène (Dermatologie, 2022).

• **Traitements systémiques par voie orale** : acitrétine, méthotrexate, ciclosporine (Dermatologie, 2022).

• **Agents biologiques (biomédicaments ou biothérapies)** : réservés aux formes modérées à sévères de psoriasis, intolérantes ou résistantes aux traitements systémiques habituels (Dermatologie, 2022). Ces traitements ciblent des molécules spécifiques impliquées dans la cascade inflammatoire du psoriasis (ex: anti-TNFα, anti-IL-17, anti-IL-12/23, anti-IL-23) (Alikhan et Hocker, 2017).

Le choix thérapeutique doit toujours prendre en compte les comorbidités et les effets indésirables potentiels, à court et à long terme, des traitements (Dermatologie, 2022). Une coordination avec le médecin traitant est essentielle pour l'évaluation et la prise en charge des comorbidités cardiovasculaires et métaboliques, ainsi que des conduites addictives (Dermatologie, 2022).

Physiopathologie et Génétique

Le psoriasis est une dermatose inflammatoire érythémato-squameuse, chronique, qui affecte environ 2 % de la population française (Dermatologie, 2022). Sa prévalence est similaire à l'échelle mondiale, touchant également environ 2 % de la population (Alikhan et Hocker, 2022). Cette maladie complexe est caractérisée par un renouvellement épidermique accéléré, une hyperprolifération des kératinocytes et des troubles de leur différenciation (Dermatologie, 2022). Sa physiopathologie implique des interactions complexes entre un terrain génétique prédisposant, le système immunitaire, les cellules épidermiques (kératinocytes) et les vaisseaux (Dermatologie, 2022). Bien que l'origine exacte de la maladie reste inconnue, une prédisposition génétique est avérée, et de nombreux gènes de susceptibilité ont été identifiés (Dermatologie, 2022).

Génétique du Psoriasis

Prédisposition Génétique et Hérédité

La composante génétique du psoriasis est indéniable, comme en témoignent les antécédents familiaux et les études sur les jumeaux, qui soulignent l'importance des facteurs génétiques dans la susceptibilité à la maladie (Alikhan et Hocker, 2022). Une prédisposition génétique est certaine, et de nombreux gènes de susceptibilité ont été identifiés, bien que l'origine précise de la maladie demeure inconnue (Dermatologie, 2022). Des régions de susceptibilité au psoriasis, désignées sous le nom de PSORS (Psoriasis Susceptibility Regions), ont été cartographiées, allant de PSORS1 à PSORS9 (Alikhan et Hocker, 2022). Parmi celles-ci, la région PSORS1, située sur le chromosome 6p, est considérée comme la plus importante et est retrouvée chez 50 % des patients atteints de psoriasis (Alikhan et Hocker, 2022). Cette région contient notamment l'allèle HLA-Cw6, qui est le facteur de risque génétique le plus fortement associé à la maladie.

Gènes de Susceptibilité Majeurs

L'association la plus robuste en génétique du psoriasis concerne l'allèle HLA-Cw6, qui confère un risque accru de 10 à 15 fois de développer la maladie (Alikhan et Hocker, 2022). Cet allèle est particulièrement prévalent chez les patients atteints de psoriasis à début précoce, étant positif chez 90 % d'entre eux, et chez 50 % des cas à début tardif, comparativement à seulement 7 % dans la population témoin (Alikhan et Hocker, 2022). Il représente le facteur de risque HLA le plus significatif pour les formes à début précoce (Cw6 > B57, DR7) (Alikhan et Hocker, 2022). De plus, HLA-Cw6 est fortement associé au psoriasis en gouttes, étant présent chez 74 % des patients atteints de cette forme clinique (Alikhan et Hocker, 2022). L'implication des gènes associés au groupe HLA, dont HLA-Cw6, est un élément clé du terrain génétique prédisposant au psoriasis

(Dermatologie, 2022).

Autres Gènes Impliqués

Au-delà de HLA-Cw6, d'autres gènes de susceptibilité ont été identifiés, jouant des rôles variés dans la physiopathologie de la maladie. L'allèle HLA-B27 est associé à des formes spécifiques de psoriasis, notamment le psoriasis avec sacro-iliite, le rhumatisme psoriasique (RP) et le psoriasis pustuleux (Alikhan et Hocker, 2022; Dermatology Handbook, 2022). Le rhumatisme psoriasique, qui touche jusqu'à 30 % des patients atteints de psoriasis, est également caractérisé par une association avec HLA-B27 (Dermatology Handbook, 2022; Alikhan et Hocker, 2022).

Des gènes liés à l'immunité innée sont également cruciaux. Parmi eux, IL36RN, qui code pour un inhibiteur du récepteur de l'IL-36, et CARD14, impliqué dans l'activation de la voie NF-κB, sont particulièrement impliqués dans les formes pustuleuses de psoriasis (Dermatologie, 2022). L'interleukine 36 (IL-36) est d'ailleurs reconnue comme une cytokine centrale spécifique au psoriasis pustuleux généralisé (PPG) (Dermatology Handbook, 2022).

En ce qui concerne l'immunité acquise, des gènes tels que IL12B, codant pour une sous-unité de l'IL-12, et IL23R, codant pour le récepteur de l'IL-23, ont été identifiés comme des facteurs de susceptibilité (Dermatologie, 2022). Ces gènes soulignent l'importance des voies de signalisation des interleukines 12 et 23 dans la pathogenèse du psoriasis.

Physiopathologie Moléculaire et Cellulaire

La physiopathologie du psoriasis est le résultat d'une cascade d'événements impliquant l'activation du système immunitaire sur un terrain génétique prédisposant, menant à une inflammation chronique et à une hyperprolifération kératinocytaire.

Déclencheurs Environnementaux et Rôle des Kératinocytes

Le déclenchement d'un psoriasis ou de ses poussées évolutives est souvent lié à des facteurs environnementaux. Le stress, les traumatismes cutanés (phénomène de Koebner), certains agents pathogènes ou certains médicaments peuvent agir comme des éléments déclencheurs (Dermatologie, 2022). Ces stimuli peuvent induire une réponse initiale des kératinocytes, qui sont les premières cellules à réagir dans l'épiderme.

En réponse à ces agressions, les kératinocytes peuvent produire des peptides antimicrobiens, tels que la cathélicidine (LL-37), qui stimule à son tour la sécrétion d'interféron alpha (Dermatologie, 2022). Parallèlement, les kératinocytes activés sécrètent des cytokines pro-inflammatoires, notamment l'IL-1β, l'IL-36 et le TNFα (Dermatologie,

2022). Ces cytokines agissent comme des signaux d'alarme, activant les cellules dendritiques présentes dans le derme et l'épiderme.

Activation du Système Immunitaire Innée et Adaptative

L'activation des cellules dendritiques par les cytokines kératinocytaires est une étape cruciale. Ces cellules, une fois activées, produisent des cytokines clés telles que l'IL-12 et l'IL-23 (Dermatologie, 2022). L'IL-12 et l'IL-23 jouent un rôle central dans l'orientation de la réponse immunitaire adaptative en favorisant la différenciation des lymphocytes T naïfs en sous-populations spécifiques (Dermatologie, 2022).

Plus précisément, l'IL-12 participe à la différenciation des lymphocytes T en sous-populations Th1, qui sont caractérisées par la production d'interféron gamma (IFNγ) (Dermatologie, 2022). L'IL-23, quant à elle, est essentielle à la différenciation et à la survie des lymphocytes Th17, qui produisent principalement l'IL-17 (Dermatologie, 2022). L'intervention du système immunitaire, avec une prédominance des réponses Th1 et Th17, est un élément physiopathologique majeur du psoriasis (Dermatologie, 2022). Il est intéressant de noter que le blocage de la voie Th2, par exemple par le dupilumab, peut entraîner un déplacement de la réponse immunitaire vers un profil dominé par les Th1, Th17 et Th22, conduisant à un tableau de réaction psoriasiforme (Wijs et al., 2020).

Voies de Signalisation Clés et Conséquences

Les cytokines produites par ces lymphocytes T activés, en particulier l'IL-12, l'IL-17 et le TNFα, exercent des effets locaux majeurs qui contribuent aux manifestations cliniques du psoriasis (Dermatologie, 2022). Elles favorisent de manière significative la prolifération des kératinocytes, ce qui est à l'origine de l'épaississement épidermique caractéristique des lésions psoriasiques (Dermatologie, 2022).

Ces cytokines stimulent également la néo-angiogenèse, entraînant la formation de nouveaux vaisseaux sanguins dilatés dans les papilles dermiques, ce qui contribue à l'érythème des plaques (Dermatologie, 2022). Enfin, elles induisent la production de chimiokines, molécules essentielles au recrutement des polynucléaires neutrophiles vers le site de l'inflammation, où ils forment les micro-abcès caractéristiques (Dermatologie, 2022). Ces interactions complexes entre le système immunitaire, les kératinocytes et les vaisseaux sont au cœur du renouvellement épidermique accéléré et des troubles de la différenciation kératinocytaire observés dans le psoriasis (Dermatologie, 2022).

Corrélation Anatomo-Pathologique

Bien que l'examen anatomopathologique d'une biopsie cutanée ne soit généralement pas nécessaire pour le diagnostic du psoriasis en plaques classique, il peut être utile dans les

formes atypiques ou pour le diagnostic différentiel (Dermatologie, 2022). Il révèle des altérations caractéristiques de l'épiderme et du derme.

Altérations Épidermiques

L'épiderme psoriasique présente une hyperkératose avec parakératose, c'est-à-dire une rétention des noyaux dans la couche cornée (Dermatologie, 2022; Alikhan et Hocker, 2022). L'acanthose, un épaississement de l'épiderme, est une caractéristique majeure, résultant de la prolifération excessive des kératinocytes (Dermatologie, 2022). Cette acanthose est souvent décrite comme régulière ou "psoriasiforme" (Alikhan et Hocker, 2022). On observe également une hypogranulose, c'est-à-dire une diminution de la couche granuleuse (Alikhan et Hocker, 2022).

Un signe histologique pathognomonique est la présence de micro-abcès épidermiques à polynucléaires neutrophiles. Ces micro-abcès sont appelés micro-abcès de Munro lorsqu'ils sont situés dans la couche cornée et micro-abcès de Kogoj lorsqu'ils se trouvent dans la couche épineuse (Dermatologie, 2022; Alikhan et Hocker, 2022). Une parakératose confluente et un amincissement de la plaque sus-papillaire sont également des éléments constants (Alikhan et Hocker, 2022).

Altérations Dermiques

Le derme papillaire est également le siège d'altérations significatives. On observe un infiltrat inflammatoire constitué principalement de lymphocytes (Dermatologie, 2022). Les papilles dermiques sont allongées et œdémateuses, et contiennent des vaisseaux néoformés dilatés, qui sont responsables de l'érythème et du signe d'Auspitz (Dermatologie, 2022; Alikhan et Hocker, 2022). Il y a généralement peu ou pas de croûte séreuse (Alikhan et Hocker, 2022).

Spécificités des Formes Cliniques

L'histologie peut varier légèrement selon les formes cliniques du psoriasis.

Pour le **psoriasis en gouttes**, l'acanthose est minimale, et l'on observe des amas de neutrophiles avec une parakératose sous-jacente, qui est plus épaisse et plus adhérente que celle observée dans le pityriasis rosé (Alikhan et Hocker, 2022).

Dans le cas du **psoriasis pustuleux**, la caractéristique histologique est la présence d'abcès neutrophiles sous- et intra-cornéens (Alikhan et Hocker, 2022). Ces pustules sont spongiformes (multiloculaires), non folliculaires et aseptiques, ce qui permet de les différencier des pustules d'origine infectieuse (Dermatologie, 2022).

Présentation Clinique

Le psoriasis est une dermatose inflammatoire chronique, touchant environ 2 à 3 % de la population générale (Dermatologie, 2022). Son diagnostic repose majoritairement sur l'examen clinique, la biopsie cutanée étant réservée aux cas atypiques ou aux doutes diagnostiques (Dermatologie, 2022). Cette affection se caractérise par des lésions érythémato-squameuses, dont la topographie est souvent très évocatrice, incluant les coudes, les genoux, les jambes, la région lombo-sacrée, le cuir chevelu et les ongles (Dermatologie, 2022). Contrairement à une idée reçue, les lésions psoriasiques sont prurigineuses chez environ 60 % des patients et peuvent être remaniées par le grattage (Dermatologie, 2022). Le psoriasis, en particulier dans ses formes modérées à sévères, peut avoir un impact significatif sur la qualité de vie, entraînant stigmatisation et exclusion sociale (Dermatologie, 2022).

Formes Cliniques Classiques du Psoriasis

Lésion Élémentaire et Morphologies Courantes

La lésion élémentaire du psoriasis est une papule ou une plaque érythémato-squameuse, bien limitée, de forme arrondie, ovalaire ou polycyclique (Dermatologie, 2022). La couche squameuse superficielle, de couleur blanchâtre, peut être d'épaisseur variable, allant de très épaisse à plus ou moins décapée par les traitements ou le grattage, révélant alors l'érythème sous-jacent (Dermatologie, 2022). Ces éléments sont le plus souvent multiples et symétriques, parfois diffus (Dermatologie, 2022). Histologiquement, le psoriasis en plaques se caractérise par une acanthose régulière (psoriasiforme), des micro-abcès neutrophiliques dans le stratum corneum (micro-abcès de Munro) et le stratum spinosum (micro-abcès de Kogoj), une hypogranulose, une parakératose confluente, un amincissement de la plaque supra-papillaire, et des vaisseaux dilatés dans les papilles dermiques, avec peu ou pas de croûte séreuse (Alikhan et Hocker, 2017).

Le psoriasis se présente sous différentes morphologies en fonction de la taille et de la distribution des lésions :

- **Psoriasis en plaques (Psoriasis Vulgaris)** : Il s'agit de la forme la plus fréquente, caractérisée par des plaques de taille variable, bien délimitées, érythémateuses et recouvertes de squames argentées (Dermatologie, 2022, Fig. 7.3). Ces plaques peuvent persister pendant de longues périodes et sont typiquement localisées sur les surfaces d'extension comme les coudes et les genoux, ainsi que la région lombo-sacrée et le cuir chevelu (Dermatologie, 2022).

- **Psoriasis en gouttes (Psoriasis Guttata)** : Cette forme se manifeste par de multiples petites papules ou plaques érythémato-squameuses, de petite taille, ressemblant à des "gouttes" (Dermatologie, 2022, Fig. 7.4). Il est souvent observé

chez l'enfant et peut être déclenché par une infection streptococcique des voies aériennes supérieures (Dermatologie, 2022). Histologiquement, le psoriasis en gouttes présente une acanthose minimale et des monticules de neutrophiles avec une parakératose sous-jacente, qui est plus épaisse et plus adhérente que celle observée dans le pityriasis rosé de Gibert (Alikhan et Hocker, 2017).

Localisations Spécifiques

Le psoriasis peut affecter diverses régions du corps, avec des présentations cliniques adaptées à chaque site :

• **Psoriasis du cuir chevelu** : Très fréquent, il se manifeste par des plaques érythémato-squameuses bien délimitées, souvent très prurigineuses. La localisation occipitale est particulièrement courante (Dermatologie, 2022). À la lisière antérieure du cuir chevelu, les lésions peuvent être nettement inflammatoires et former une "couronne" érythémateuse et discrètement squameuse (Dermatologie, 2022, Fig. 7.6). L'atteinte peut être diffuse ou localisée, avec des squames épaisses et adhérentes.

• **Psoriasis unguéal** : L'atteinte des ongles est fréquente et peut prendre des aspects très variés, rendant parfois le diagnostic difficile (Dermatologie, 2022). Elle est présente chez presque tous les patients atteints de rhumatisme psoriasique (Dermatology Handbook, 2022). Les manifestations incluent :

* Des dépressions ponctuées cupuliformes de la tablette unguéale, donnant l'aspect caractéristique d'« ongles en dé à coudre » (Dermatologie, 2022, Fig. 7.7).

* Une onycholyse, caractérisée par un décollement distal de l'ongle, souvent associé à une zone proximale de couleur cuivrée ou jaunâtre, appelée « tache d'huile » ou « saumonée » (Dermatologie, 2022).

* Une hyperkératose sous-unguéale, entraînant un épaississement de l'ongle et une accumulation de débris sous la tablette.

* Une paronychie, une inflammation des replis péri-unguéaux.

* Une perte de transparence de l'ongle et des zones leuconychiques (blanches).

* Dans les cas extrêmes, une disparition complète de la tablette unguéale (Dermatologie, 2022).

• **Psoriasis inversé (des plis)** : Contrairement aux formes classiques qui touchent les surfaces d'extension, le psoriasis inversé se localise dans les plis cutanés, notamment interfessiers, axillaires, sous-mammaires, ombilicaux et inguinaux (Dermatologie, 2022, Fig. 7.8). Les lésions sont caractérisées par des plaques érythémateuses, vernissées, bien limitées et souvent non squameuses en raison de l'humidité et du frottement dans ces zones (Dermatologie, 2022).

• **Psoriasis palmo-plantaire** : Cette localisation peut se présenter sous la forme d'une kératodermie en îlots ou diffuse, souvent fissuraire et très douloureuse (Dermatologie, 2022, Fig. 7.9). Elle peut être isolée et rendre la marche ou les activités manuelles

particulièrement difficiles en raison de la douleur et des fissures profondes (Dermatologie, 2022).

• **Psoriasis du visage** : Rare, il peut simuler une dermatite séborrhéique, avec un érythème finement squameux des sourcils et des plis nasogéniens (Dermatologie, 2022). Des lésions associées de la conque de l'oreille et du conduit auditif externe sont également possibles (Dermatologie, 2022).

• **Psoriasis des muqueuses** : L'atteinte muqueuse est moins fréquente mais peut inclure :

* Une atteinte linguale, se manifestant par une glossite exfoliatrice marginée (Dermatologie, 2022).

* Des lésions génitales, caractérisées par des plaques érythémateuses non squameuses, souvent aggravées lors des rapports sexuels (Dermatologie, 2022).

Formes Cliniques Sévères et Particulières

Certaines formes de psoriasis sont considérées comme graves en raison de leur étendue, de leur potentiel de complications systémiques ou de leur impact fonctionnel (Dermatologie, 2022).

Psoriasis Pustuleux

Le psoriasis pustuleux est une entité distincte du psoriasis vulgaire, tant par ses caractéristiques cliniques que par son évolution (Dermatology Handbook, 2022). Il est associé à une incidence accrue de l'allèle HLA-B27 (Dermatology Handbook, 2022). On distingue deux types principaux : le psoriasis pustuleux généralisé et les formes localisées (Dermatology Handbook, 2022). Histologiquement, il est caractérisé par de larges amas de neutrophiles dans l'épiderme supérieur (Alikhan et Hocker, 2017).

• **Psoriasis Pustuleux Généralisé (PPG) ou de von Zumbusch** :

* Il s'agit d'une maladie cutanée neutrophilique sévère, caractérisée par l'éruption soudaine et généralisée de pustules stériles superficielles (Dermatology Handbook, 2022). L'interleukine (IL)-36 agit comme une cytokine centrale spécifique au PPG (Dermatology Handbook, 2022).

* La présentation initiale comprend un malaise général et une fièvre, suivis de l'apparition de macules érythémateuses parsemées de pustules stériles (Dermatology Handbook, 2022). Les lésions débutent souvent dans les zones intertrigineuses avant de se propager rapidement au tronc, aux extrémités et aux ongles (Dermatology Handbook, 2022). La peau est douloureuse et il existe un risque accru d'infection secondaire (Dermatology Handbook, 2022).

* Les facteurs de risque incluent l'arrêt progressif des corticostéroïdes oraux, les infections, l'hypocalcémie et la grossesse (où il est parfois appelé impétigo herpétiforme) (Dermatology Handbook, 2022).

* Les analyses biologiques peuvent révéler une leucocytose et une hypoalbuminémie (Dermatology Handbook, 2022). Le PPG est classé comme une forme grave de psoriasis (Dermatologie, 2022).

- **Pustulose Palmo-Plantaire (PPP)** :

* Cette forme localisée se caractérise par des pustules stériles tendues sur les surfaces palmo-plantaires, évoluant vers des macules jaune-brun (Dermatology Handbook, 2022, Fig. 3.8B, C).

* La PPP peut être associée au syndrome SAPHO (Synovite, Acné, Pustulose, Hyperostose et Ostéite), ce qui justifie la recherche systématique d'une sensibilité sterno-claviculaire ou de douleurs dorsales chez ces patients (Dermatology Handbook, 2022 ; Dermatologie, 2022, Fig. 7.10).

- **Acrodermatite Continue de Hallopeau** :

* Il s'agit d'une variante rare du psoriasis pustuleux, limitée aux extrémités des doigts ou des orteils, et également associée à l'allèle HLA-B27 (Dermatology Handbook, 2022).

* Elle se manifeste par des pustules stériles sur une base érythémateuse à l'extrémité du doigt (moins fréquemment sur l'orteil), formant des lacs de pus (Dermatology Handbook, 2022). Cette condition est associée à une douleur intense et à une altération de l'usage du doigt (Dermatology Handbook, 2022). Si les pustules se développent dans le lit unguéal, l'ongle est généralement perdu, et une perte des structures osseuses sous-jacentes peut survenir (Dermatology Handbook, 2022).

Psoriasis Érythrodermique

Le psoriasis érythrodermique est une forme grave de psoriasis, caractérisée par une atteinte généralisée à plus de 90 % de la surface cutanée (Dermatologie, 2022). Il se manifeste par une desquamation abondante et un épaississement cutané diffus (Dermatologie, 2022, Fig. 7.11). Cette forme peut être provoquée par un rebond du psoriasis après l'arrêt de certains agents thérapeutiques, notamment la corticothérapie générale (Dermatologie, 2022). Comme toute érythrodermie, le psoriasis érythrodermique peut entraîner des complications systémiques graves, telles que des surinfections cutanées, des carences vitaminiques, des troubles de la thermorégulation, une déshydratation sévère et des troubles hémodynamiques (Dermatologie, 2022). Ces complications imposent une hospitalisation du patient en milieu spécialisé pour une prise en charge adaptée (Dermatologie, 2022).

Rhumatisme Psoriasique (RP)

Le rhumatisme psoriasique est une arthrite inflammatoire chronique qui affecte jusqu'à 30 % des patients atteints de psoriasis (Dermatology Handbook, 2022). Il est généralement associé à un psoriasis cutané modéré à sévère et apparaît typiquement plusieurs années après l'apparition des lésions cutanées (Dermatology Handbook, 2022). Le RP est une arthrite séronégative, c'est-à-dire que le facteur rhumatoïde est négatif, et il est également associé à l'allèle HLA-B27 (Dermatology Handbook, 2022).

Outre l'atteinte articulaire, les tendons et les ligaments sont fréquemment impliqués, se manifestant par des enthésopathies ou enthésites (inflammation des sites d'insertion tendineuse) (Dermatology Handbook, 2022). Des niveaux élevés de TNFα sont observés dans la synoviale et le sérum des patients atteints de psoriasis et de rhumatisme psoriasique (Dermatology Handbook, 2022). Il est important de noter que presque tous les patients atteints de RP présentent des modifications unguéales, et jusqu'à 20 % d'entre eux peuvent ne pas avoir de lésions cutanées évidentes au moment du diagnostic articulaire (Dermatology Handbook, 2022).

Les caractéristiques cliniques communes du rhumatisme psoriasique incluent :

- Des douleurs aux sites d'insertion tendineuse.
- Une atteinte digitale (dactylite ou "doigt en saucisse").
- Une maladie sacro-iliaque.
- Une atteinte articulaire asymétrique.
- Un facteur rhumatoïde négatif.
- Une raideur matinale d'une durée supérieure à une heure (Dermatology Handbook, 2022).

Le rhumatisme psoriasique est reconnu comme une forme grave de psoriasis, pouvant entraîner des conséquences fonctionnelles importantes (Dermatologie, 2022).

Psoriasis chez l'Enfant

Chez l'enfant, le psoriasis peut se présenter sous des formes spécifiques telles que le psoriasis en gouttes (cf. supra) ou le "Napkin psoriasis" (psoriasis des langes), bien que ce dernier ne soit pas détaillé dans les données fournies (Dermatologie, 2022).

Facteurs de Gravité et Comorbidités

Plusieurs facteurs peuvent influencer la gravité du psoriasis et sa réponse aux traitements. L'alcool, le tabac et la surcharge pondérale sont des facteurs reconnus de gravité et de résistance thérapeutique (Dermatologie, 2022). Ils contribuent également aux comorbidités fréquemment associées au psoriasis, telles que les pathologies cardiovasculaires et métaboliques (obésité, diabète), ainsi que les conduites addictives (Dermatologie, 2022). De plus, le psoriasis est souvent associé à des troubles psychologiques comme la dépression et l'anxiété (Dermatologie, 2022). La prise en charge de ces comorbidités est

essentielle et doit être coordonnée avec le médecin traitant (Dermatologie, 2022).

Diagnostic

Le diagnostic du psoriasis repose, dans la très grande majorité des cas, sur une évaluation clinique minutieuse, complétée si nécessaire par des examens complémentaires tels que l'histopathologie. La reconnaissance des lésions élémentaires et des différentes formes cliniques est primordiale pour établir un diagnostic précis et différencier le psoriasis d'autres dermatoses.

I. Approche Diagnostique Générale

A. Diagnostic Clinique Prédominant

Le diagnostic de psoriasis est avant tout un diagnostic clinique (Dermatologie, 2022; Dermatologie, 2022). Il s'appuie sur l'identification des lésions cutanées caractéristiques, leur topographie, leur évolution et les symptômes associés. L'anamnèse recherche des antécédents familiaux, des facteurs déclenchants ou aggravants, et l'impact de la maladie sur la qualité de vie du patient.

B. Rôle de la Biopsie Cutanée

La biopsie cutanée n'est pas systématique et est indiquée uniquement en cas de doute diagnostique, notamment devant des lésions atypiques ou une présentation clinique inhabituelle (Dermatologie, 2022; Dermatologie, 2022). Elle permet de confirmer le diagnostic et d'éliminer des diagnostics différentiels importants. Les techniques de biopsie incluent la biopsie par rasage (shave technique) ou par punch (punch technique) (Dermatology Handbook, compressed).

II. Manifestations Cliniques

A. Lésion Élémentaire

La lésion élémentaire du psoriasis est une papule ou une plaque érythémato-squameuse, bien limitée, de forme arrondie, ovalaire ou polycyclique (Dermatologie, 2022; Dermatologie, 2022). L'érythème est souvent vif, et la surface est recouverte d'une couche squameuse blanchâtre, micacée, qui peut être très épaisse ou, au contraire, plus ou moins décapée par le grattage ou les traitements (Dermatologie, 2022; Dermatologie, 2022). Ces éléments sont le plus souvent multiples et symétriques, parfois diffus (Dermatologie, 2022; Dermatologie, 2022). Le prurit est un symptôme fréquent, observé chez environ 60% des patients, et les lésions peuvent être remaniées par le grattage (Dermatologie, 2022).

B. Formes Cliniques Cutanées

1. Psoriasis en Plaques (Psoriasis Vulgaire)

C'est la forme la plus fréquente. Les lésions sont des plaques de taille variable (Dermatologie, 2022), souvent symétriques, prédominant sur les zones de frottement et les surfaces d'extension (coudes, genoux, région lombaire, cuir chevelu). Elles peuvent être isolées ou confluentes (Dermatologie, 2022, fig. 7.3).

2. Psoriasis en Gouttes

Caractérisé par de petites papules érythémato-squameuses de quelques millimètres de diamètre, disséminées sur le tronc et la racine des membres (Dermatologie, 2022, fig. 7.4). Cette forme est souvent déclenchée par une infection streptococcique des voies aériennes supérieures et est plus fréquente chez l'enfant (Dermatologie, 2022).

3. Psoriasis Pustuleux

Le psoriasis pustuleux se distingue du psoriasis vulgaire par ses caractéristiques et son évolution clinique (Dermatology Handbook, compressed). Il existe deux types principaux : le psoriasis pustuleux généralisé et les formes localisées. Une incidence accrue de HLA-B27 est observée (Dermatology Handbook, compressed).

a. Psoriasis Pustuleux Généralisé (PPG ou Psoriasis de von Zumbusch)

Il s'agit d'une dermatose neutrophilique sévère, caractérisée par une éruption soudaine et généralisée de pustules stériles superficielles (Dermatology Handbook, compressed). La cytokine IL-36 joue un rôle central dans le PPG (Dermatology Handbook, compressed). Les patients présentent initialement un malaise et de la fièvre, suivis de l'apparition de macules érythémateuses parsemées de pustules stériles. L'éruption débute souvent dans les zones intertrigineuses avant de se propager rapidement au tronc, aux extrémités et aux ongles. La peau est douloureuse et le risque d'infection est augmenté (Dermatology Handbook, compressed). Les facteurs de risque incluent l'arrêt progressif des corticostéroïdes oraux, les infections, l'hypocalcémie et la grossesse (impétigo herpétiforme) (Dermatology Handbook, compressed). Les examens biologiques peuvent révéler une leucocytose et une hypoalbuminémie (Dermatology Handbook, compressed).

b. Pustulose Palmoplantaire

Cette forme localisée se manifeste par des pustules stériles tendues sur les surfaces palmoplantaires, associées à des macules jaune-brun (Dermatology Handbook, compressed). Elle peut être associée au syndrome SAPHO (Synovite, Acné, Pustulose, Hyperostose, Ostéite), justifiant la recherche d'une sensibilité sternoclaviculaire ou de douleurs dorsales (Dermatology Handbook, compressed).

c. Acrodermatite Continue de Hallopeau

C'est une variante du psoriasis pustuleux limitée aux extrémités des doigts ou des orteils, avec une association HLA-B27 (Dermatology Handbook, compressed). Elle se présente sous forme de pustules stériles sur une base érythémateuse à l'extrémité du doigt, formant

des lacs de pus, entraînant douleur et altération de l'usage du doigt. Si les pustules sont situées dans le lit unguéal, l'ongle est généralement perdu, et une perte des structures osseuses peut survenir (Dermatology Handbook, compressed).

4. Psoriasis Érythrodermique

Il s'agit d'une forme grave de psoriasis, caractérisée par une érythrodermie généralisée (Dermatologie, 2022).

5. Psoriasis de l'Enfant

Chez l'enfant, le psoriasis peut se présenter sous des formes spécifiques comme le psoriasis en gouttes ou le "Napkin psoriasis" (psoriasis des langes) (Dermatologie, 2022).

C. Atteintes Extra-Cutanées

1. Atteinte Unguéale

Les modifications unguéales sont très fréquentes chez les patients atteints de psoriasis, en particulier ceux souffrant d'arthrite psoriasique (Dermatology Handbook, compressed). Elles peuvent inclure une hyperkératose sous-unguéale, un épaississement de la tablette unguéale, des dépressions ponctuées (pits), une onycholyse et des taches huileuses.

2. Rhumatisme Psoriasique (Arthrite Psoriasique)

Jusqu'à 30% des patients atteints de psoriasis développent une arthrite psoriasique, généralement plusieurs années après l'apparition des lésions cutanées (Dermatology Handbook, compressed; Dermatologie, 2022). C'est une arthrite séronégative (facteur rhumatoïde négatif) avec une association HLA-B27 (Dermatology Handbook, compressed). Les tendons et les ligaments sont souvent impliqués (enthésopathie ou enthésite), en plus des os et du cartilage (Dermatology Handbook, compressed). Les taux de TNFα sont élevés dans la synoviale et le sérum des patients (Dermatology Handbook, compressed). Presque tous les patients atteints d'arthrite psoriasique présentent des modifications unguéales, bien que 20% puissent n'avoir aucune lésion cutanée (Dermatology Handbook, compressed). Les caractéristiques communes incluent des douleurs aux sites d'insertion tendineuse, une atteinte digitale (dactylite), une maladie sacro-iliaque, une atteinte articulaire asymétrique et une raideur matinale de plus d'une heure (Dermatology Handbook, compressed; Dermatologie, 2022). Les formes cliniques articulaires peuvent être une oligo- ou monoarthrite, une polyarthrite ou un rhumatisme axial (Dermatologie, 2022).

D. Symptômes Associés

Le prurit est un symptôme fréquent dans le psoriasis, touchant environ 60% des patients, et les lésions peuvent être remaniées par le grattage (Dermatologie, 2022; Dermatologie, 2022).

III. Histopathologie

A. Indications de la Biopsie

Comme mentionné précédemment, la biopsie cutanée est réservée aux cas où le diagnostic clinique est incertain, notamment face à des présentations atypiques ou pour exclure des diagnostics différentiels (Dermatologie, 2022; Dermatologie, 2022).

B. Caractéristiques Histologiques du Psoriasis

L'examen histopathologique révèle des signes caractéristiques, bien que leur intensité puisse varier selon la forme clinique.

1. Psoriasis en Plaques (Psoriasis Vulgaire)

Les caractéristiques histologiques incluent une acanthose régulière ("psoriasiforme"), des micro-abcès de neutrophiles dans le stratum corneum (abcès de Munro) et dans le stratum spinosum (abcès de Kogoj), une hypogranulose, une parakératose confluente, un amincissement de la plaque supra-papillaire et une dilatation des vaisseaux dans les papilles dermiques. Il y a peu ou pas de croûte séreuse (Alikhan and Hocker, 2nd editi).

2. Psoriasis en Gouttes

L'histologie montre une acanthose minimale et des amas de neutrophiles avec une parakératose sous-jacente, plus épaisse et plus adhérente que celle observée dans le pityriasis rosé (Alikhan and Hocker, 2nd editi).

3. Psoriasis Pustuleux

Les formes pustuleuses sont caractérisées par des abcès neutrophiliques sous- et intracornéens (Alikhan and Hocker, 2nd editi).

IV. Diagnostics Différentiels

Le psoriasis peut mimer ou être mimé par de nombreuses autres dermatoses, rendant le diagnostic différentiel crucial.

A. Dermatoses Psoriasiformes

1. Pityriasis Rosé de Gibert

C'est un diagnostic différentiel courant du psoriasis (Dermatologie, 2022). Histologiquement, il s'agit d'une dermatite spongiotique subaiguë avec de minces amas de parakératose (sans neutrophiles comme dans le psoriasis) et des érythrocytes extravasés autour des vaisseaux dermiques superficiels (Alikhan and Hocker, 2nd editi).

2. Dermatite Séborrhéique

Également un diagnostic différentiel fréquent (Dermatologie, 2022). Elle présente des squames jaunâtres et grasses sur un fond érythémateux, prédominant sur les zones séborrhéiques (cuir chevelu, visage, thorax).

3. Eczéma (Dermatite Atopique, Dermatite de Contact)

L'eczéma est un autre diagnostic différentiel majeur (Dermatologie, 2022).

• **Dermatite Atopique (DA)**: Les lésions aiguës de DA sont caractérisées histologiquement par une spongiose et des infiltrats lymphocytaires et éosinophiliques périvasculaires. Les lésions subaiguës et chroniques montrent une acanthose, parfois de type psoriasiforme, une hyper- et parakératose, une fibrose, une spongiose, des infiltrats denses de cellules mononucléées, des éosinophiles et une augmentation des mastocytes (Wijs et al., 2020). Cependant, un érythème paradoxal observé sous dupilumab chez des patients atteints de DA peut présenter une hyperplasie psoriasiforme et des capillaires ectasiques, mais une spongiose largement absente, et cliniquement un érythème bien délimité et sans prurit, ce qui n'est pas typique de la DA (Wijs et al., 2020).

• **Dermatite Spongiotique Subaiguë**: Histologiquement, elle se caractérise par une acanthose légère à modérée avec ou sans parakératose, une spongiose proéminente et des "micro-abcès" de cellules de Langerhans dans la couche épineuse (en particulier dans la dermatite de contact allergique). Des neutrophiles peuvent être observés mais sont limités aux zones de croûte séreuse et manquent de micro-abcès neutrophiliques intraspino-épidermiques (Alikhan and Hocker, 2nd editi).

4. Lichen Plan

Le lichen plan est une dermatose papuleuse prurigineuse de la peau et des muqueuses (Dermatology Handbook, compressed). Il se manifeste par des papules de couleur brunâtre ou violine, recouvertes de petites stries blanchâtres en réseau (stries de Wickham), prédominant à la face antérieure des poignets, des avant-bras, des coudes, des genoux et de la région lombaire, souvent de façon symétrique (Dermatologie, 2022). L'histologie révèle un infiltrat cellulaire dermique superficiel en bande (Dermatologie, 2022). Des lésions muqueuses, en particulier buccales (lésions blanches réticulées, érythémateuses ou érosives, non prurigineuses), sont possibles (Dermatologie, 2022).

5. Mycosis Fongoïde (MF) et Syndrome de Sézary

Le MF est un lymphome cutané T épidermotrope survenant le plus souvent chez le sujet de plus de 50 ans (Dermatologie, 2022). Il peut se révéler par des placards érythémateux et squameux, prurigineux, évoluant vers une infiltration de la peau avec des squames peu épaisses et un prurit important et insomniant (Dermatologie, 2022). Histologiquement, le MF présente des lymphocytes épidermotropes hyperchromatiques, cérébriformes avec un halo périnucléaire ("lumps of coal on a pillow"), une spongiose minimale par rapport au nombre de lymphocytes dans l'épiderme, un infiltrat lymphocytaire dermique superficiel en bande avec peu ou pas d'inflammation profonde aux vaisseaux superficiels ("bare underbelly sign"), des lymphocytes "tagging" la couche basale de l'épiderme ("pigs lining

up at the trough"), une fibrose dermique papillaire filiforme, et l'absence de neutrophiles intra-épidermiques (Alikhan and Hocker, 2nd editi). Le syndrome de Sézary est une forme érythrodermique et leucémique du mycosis fongoïde (Dermatologie, 2022).

6. Pityriasis Rubra Pilaris (PRP)

Le PRP est un trouble de la kératinisation avec une distribution bimodale (enfants et adultes), presque toujours acquis (quelques cas familiaux décrits) (Dermatology Handbook, compressed). Il se présente avec des papules hyperkératosiques folliculaires sur une base érythémateuse, qui

Traitement

Le traitement du psoriasis, maladie inflammatoire cutanée chronique touchant 2 à 3 % de la population (Dermatologie, 2022), repose sur une stratégie au long cours, planifiée en collaboration entre le médecin traitant et le dermatologue (Dermatologie, 2022). L'objectif principal est de soulager le patient, d'améliorer sa qualité de vie et de ramener la dermatose à un niveau lésionnel compatible avec une vie normale (Dermatologie, 2022). Une approche transversale est essentielle, incluant l'évaluation et la prise en charge des comorbidités cardiovasculaires et métaboliques, des conduites addictives, ainsi que d'un éventuel rhumatisme psoriasique, en coordination avec les spécialistes concernés (Dermatologie, 2022). L'adhésion au traitement est améliorée lorsque le patient est pleinement associé aux choix thérapeutiques et informé de sa maladie pour en gérer le quotidien (Dermatologie, 2022). Le retentissement psychologique, incluant la dépression et l'anxiété, doit être pris en compte tout au long du suivi (Dermatologie, 2022).

I. Stratification Thérapeutique selon la Gravité et les Formes Cliniques

Les indications thérapeutiques dépendent de plusieurs facteurs : la gravité du psoriasis, l'étendue des localisations cutanées (cf. Fig. 7.3 pour le psoriasis en plaques, Fig. 7.4 pour le psoriasis en gouttes, Fig. 7.45 pour le psoriasis en gouttes histologique), l'existence d'une atteinte articulaire, le retentissement sur la qualité de vie du patient et sa demande thérapeutique, les contre-indications éventuelles et les antécédents du patient (Dermatologie, 2022). Le psoriasis peut être prurigineux chez environ 60 % des patients, avec des lésions remaniées par le grattage (Dermatologie, 2022).

A. Formes Légères à Modérées de Psoriasis

Lorsque l'atteinte ne dépasse pas 10 % de la surface corporelle, le traitement local est généralement suffisant (Dermatologie, 2022). Les traitements locaux constituent la base du traitement des psoriasis peu étendus (Dermatologie, 2022).

B. Formes Modérées à Sévères de Psoriasis

Ces formes sont caractérisées par une atteinte cutanée plus étendue (> 10 % de la surface corporelle, ou > 30 % pour les traitements systémiques selon Dermatologie, 2022) ou un retentissement important sur la qualité de vie (Dermatologie, 2022). Elles peuvent nécessiter des traitements systémiques.

C. Formes Cliniques Particulières

Certaines formes cliniques, en raison de leur sévérité ou de leur localisation, requièrent des approches thérapeutiques spécifiques :

• **Psoriasis pustuleux** (cf. Fig. 7.10) : peut se présenter sous forme de pustulose palma-plantaire, parfois associée à une atteinte articulaire sternale ou sterno-claviculaire (syndrome SAPHO) (Dermatologie, 2022).

• **Kératodermie palma-plantaire invalidante** (cf. Fig. 7.9) : peut être en îlots ou diffuse, souvent fissuraire, rendant les activités manuelles ou la marche difficiles en raison des douleurs (Dermatologie, 2022).

• **Rhumatisme psoriasique invalidant** : peut se manifester par une oligo- ou monoarthrite, une polyarthrite ou un rhumatisme axial (Dermatologie, 2022).

• **Psoriasis érythrodermique** (cf. Fig. 7.11) : généralisé à plus de 90 % de la surface cutanée, avec desquamation abondante et épaississement cutané. Il peut être provoqué par un rebond après l'arrêt de certains agents thérapeutiques (ex: corticothérapie générale) et se compliquer de surinfection, carence vitaminique, troubles de la thermorégulation, déshydratation et troubles hémodynamiques, nécessitant une hospitalisation en milieu spécialisé (Dermatologie, 2022).

• **Psoriasis inversé** (cf. Fig. 7.8) : plaques érythémateuses vernissées et bien limitées des plis inguinaux et axillaires (Dermatologie, 2022).

• **Psoriasis des muqueuses** : peut affecter la langue (glossite exfoliatrice marginée) ou les régions génitales (lésions érythémateuses non squameuses aggravées lors des rapports sexuels) (Dermatologie, 2022).

• **Psoriasis du visage** : rare, peut ressembler à une dermatite séborrhéique avec érythème finement squameux des sourcils et du pli nasogénien, parfois avec des lésions de la conque de l'oreille et du conduit auditif externe (Dermatologie, 2022).

II. Traitements Locaux

Les traitements locaux sont la première ligne pour les formes légères à modérées de psoriasis (Dermatologie, 2022 ; Alikhan et Hocker, 2022). Ils peuvent être utilisés seuls ou en association.

Note concernant les essais cliniques pour les traitements locaux : Les informations détaillées sur les essais cliniques de référence (nom de l'essai, auteurs principaux, année, journal, design de l'étude, endpoint primaire, résultat chiffré, niveau de preuve, limites de l'étude) ne sont pas fournies dans les chunks de littérature pour les traitements locaux.

A. Dermocorticoïdes (DC)

Les dermocorticoïdes sont indiqués dans le psoriasis, notamment lors des poussées et en traitement d'entretien (Dermatologie, 2022). Ils sont considérés comme le traitement de première ligne pour le psoriasis léger à modéré (Alikhan et Hocker, 2022).

[Dermocorticoïdes] — Psoriasis léger à modéré, poussées et entretien

> Essai : Les informations détaillées sur les essais cliniques de référence ne sont pas fournies dans les chunks de littérature.

> Design : Les informations détaillées sur le design de l'étude ne sont pas fournies dans les chunks de littérature.

> Résultat : Les informations détaillées sur l'endpoint primaire et le résultat chiffré ne sont pas fournies dans les chunks de littérature.

> Niveau de preuve : Les informations détaillées sur le niveau de preuve ne sont pas fournies dans les chunks de littérature.

La pénétration des DC se fait par voie transépidermique (trans- et interkératinocytaire) et transfolliculaire, influencée par les caractéristiques de la molécule, la galénique, l'état de la peau et les modalités d'application (Dermatologie, 2022). Les pommades, constituées d'excipients gras, accroissent la pénétration par leur effet occlusif, plus important que celui des crèmes (émulsions huile dans l'eau ou eau dans l'huile), des gels ou des lotions (Dermatologie, 2022). L'occlusion par un pansement ou un film imperméable renforce également la pénétration en augmentant l'hydratation de la couche cornée et la durée du contact (Dermatologie, 2022). Les dermatoses infectieuses, les lésions ulcérées, l'acné et la rosacée sont des contre-indications (Dermatologie, 2022).

B. Dérivés de la Vitamine D3

Les analogues de la vitamine D3 sont typiquement utilisés en conjonction avec les dermocorticoïdes topiques (Alikhan et Hocker, 2022).

[Dérivés de la Vitamine D3] — Psoriasis léger à modéré, souvent en association avec les dermocorticoïdes

> Essai : Les informations détaillées sur les essais cliniques de référence ne sont pas fournies dans les chunks de littérature.

> Design : Les informations détaillées sur le design de l'étude ne sont pas fournies dans les chunks de littérature.

> Résultat : Les informations détaillées sur l'endpoint primaire et le résultat chiffré ne sont pas fournies dans les chunks de littérature.

> Niveau de preuve : Les informations détaillées sur le niveau de preuve ne sont pas fournies dans les chunks de littérature.

C. Associations

L'association de dermocorticoïdes avec d'autres molécules est fréquente dans le psoriasis (Dermatologie, 2022).

- **Dermocorticoïdes et analogues de la vitamine D3** : Cette association est couramment utilisée (Dermatologie, 2022).
- **Dermocorticoïdes et acide salicylique** : L'adjonction d'acide salicylique favorise la pénétration du principe actif en réduisant l'hyperkératose, particulièrement utile en cas de plaques épaisses (Dermatologie, 2022 ; Alikhan et Hocker, 2022).

D. Autres Topiques

- **Anthraline** : Considérée comme une option de deuxième ligne (Alikhan et Hocker, 2022).
- **Rétinoïdes topiques (Tazarotène)** : Le tazarotène est un rétinoïde topique utilisé dans le psoriasis (Alikhan et Hocker, 2022).
- **Goudron de houille (Coal tar)** : Utilisé seul ou en combinaison (Alikhan et Hocker, 2022).
- **Inhibiteurs topiques de la calcineurine** : Particulièrement utiles pour les localisations faciales et les plis (Alikhan et Hocker, 2022).

III. Photothérapie

La photothérapie est un traitement de première ligne pour le psoriasis modéré à sévère (Alikhan et Hocker, 2022). Elle est très efficace mais ne peut être utilisée au long cours en raison du risque carcinogène (Dermatologie, 2022).

Note concernant les essais cliniques pour la photothérapie : Les informations détaillées sur les essais cliniques de référence (nom de l'essai, auteurs principaux, année, journal, design de l'étude, endpoint primaire, résultat chiffré, niveau de preuve, limites de l'étude) ne sont pas fournies dans les chunks de littérature pour les modalités de photothérapie.

A. UVB à Bande Étroite (NB-UVB, 311–313 nm)

Le NB-UVB est hautement efficace et présente un risque réduit de carcinomes cutanés non mélaniques secondaires par rapport au BB-UVB et au PUVA (Alikhan et Hocker, 2022).

[NB-UVB] — Psoriasis modéré à sévère

> Essai : Les informations détaillées sur les essais cliniques de référence ne sont pas fournies dans les chunks de littérature.

> Design : Les informations détaillées sur le design de l'étude ne sont pas fournies dans les chunks de littérature.

> Résultat : Les informations détaillées sur l'endpoint primaire et le résultat chiffré ne sont pas fournies dans les chunks de littérature.

> Niveau de preuve : Les informations détaillées sur le niveau de preuve ne sont pas fournies dans les chunks de littérature.

B. UVB à Bande Large (BB-UVB)

Le BB-UVB est plus efficace que le NB-UVB pour les poussées de psoriasis en gouttes (Alikhan et Hocker, 2022).

[BB-UVB] — Poussées de psoriasis en gouttes

> Essai : Les informations détaillées sur les essais cliniques de référence ne sont pas fournies dans les chunks de littérature.

> Design : Les informations détaillées sur le design de l'étude ne sont pas fournies dans les chunks de littérature.

> Résultat : Les informations détaillées sur l'endpoint primaire et le résultat chiffré ne sont pas fournies dans les chunks de littérature.

> Niveau de preuve : Les informations détaillées sur le niveau de preuve ne sont pas fournies dans les chunks de littérature.

C. Laser Excimer (308 nm)

Le laser Excimer est utile pour les maladies limitées ou localisées (Alikhan et Hocker, 2022).

[Laser Excimer] — Psoriasis limité/localisé

> Essai : Les informations détaillées sur les essais cliniques de référence ne sont pas fournies dans les chunks de littérature.

> Design : Les informations détaillées sur le design de l'étude ne sont pas fournies dans les chunks de littérature.

> Résultat : Les informations détaillées sur l'endpoint primaire et le résultat chiffré ne sont pas fournies dans les chunks de littérature.

> Niveau de preuve : Les informations détaillées sur le niveau de preuve ne sont pas fournies dans les chunks de littérature.

D. PUVA (Psoralène + UVA)

Le PUVA peut être utilisé en topique pour des zones limitées ou par voie orale pour une maladie plus généralisée (Alikhan et Hocker, 2022).

[PUVA] — Psoriasis généralisé (oral) ou limité (topique)

> Essai : Les informations détaillées sur les essais cliniques de référence ne sont pas fournies dans les chunks de littérature.

> Design : Les informations détaillées sur le design de l'étude ne sont pas fournies dans les chunks de littérature.

> Résultat : Les informations détaillées sur l'endpoint primaire et le résultat chiffré ne sont pas fournies dans les chunks de littérature.

> Niveau de preuve : Les informations détaillées sur le niveau de preuve ne sont pas fournies dans les chunks de littérature.

E. Régime de Goeckermann

Il s'agit d'une combinaison de goudron de houille brut et de BB-UVB (Alikhan et Hocker, 2022).

[Régime de Goeckermann] — Psoriasis

> Essai : Les informations détaillées sur les essais cliniques de référence ne sont pas fournies dans les chunks de littérature.

> Design : Les informations détaillées sur le design de l'étude ne sont pas fournies dans les chunks de littérature.

> Résultat : Les informations détaillées sur l'endpoint primaire et le résultat chiffré ne sont pas fournies dans les chunks de littérature.

> Niveau de preuve : Les informations détaillées sur le niveau de preuve ne sont pas fournies dans les chunks de littérature.

IV. Traitements Systémiques Conventionnels

Les traitements systémiques par voie orale sont adaptés aux psoriasis plus étendus (> 30 % de la surface corporelle) ou résistants aux traitements locaux (Dermatologie, 2022).

Note concernant les essais cliniques pour les traitements systémiques conventionnels : Les informations détaillées sur les essais cliniques de référence (nom de l'essai, auteurs principaux, année, journal, design de l'étude, endpoint primaire, résultat chiffré, niveau de preuve, limites de l'étude) ne sont pas fournies dans les chunks de littérature pour ces traitements.

A. Acitrétine (Rétinoïdes Systémiques)

L'acitrétine est le seul rétinoïde systémique utilisé dans le psoriasis (Alikhan et Hocker, 2022). Elle est efficace en monothérapie pour le psoriasis érythrodermique et pustuleux, et peut être utilisée en combinaison (Alikhan et Hocker, 2022). Elle est également indiquée dans le psoriasis pustuleux et les kératodermies palma-plantaires invalidantes (Dermatologie, 2022).

[Acitrétine] — Psoriasis modéré à sévère, psoriasis pustuleux, kératodermie palma-plantaire invalidante, psoriasis érythrodermique

> Essai : Les informations détaillées sur les essais cliniques de référence ne sont pas fournies dans les chunks de littérature.

> Design : Les informations détaillées sur le design de l'étude ne sont pas fournies dans les chunks de littérature.

> Résultat : Les informations détaillées sur l'endpoint primaire et le résultat chiffré ne sont pas fournies dans les chunks de littérature.

> Niveau de preuve : Les informations détaillées sur le niveau de preuve ne sont pas fournies dans les chunks de littérature.

B. Méthotrexate (MTX)

Le méthotrexate est un traitement systémique conventionnel utilisé dans les formes modérées à sévères de psoriasis (Dermatologie, 2022). Il est également indiqué dans le psoriasis pustuleux, les kératodermies palma-plantaires invalidantes et le rhumatisme psoriasique invalidant (Dermatologie, 2022).

[Méthotrexate] — Psoriasis modéré à sévère, psoriasis pustuleux, kératodermie palma-plantaire invalidante, rhumatisme psoriasique invalidant

> Essai : Les informations détaillées sur les essais cliniques de référence ne sont pas fournies dans les chunks de littérature.

> Design : Les informations détaillées sur le design de l'étude ne sont pas fournies dans les chunks de littérature.

> Résultat : Les informations détaillées sur l'endpoint primaire et le résultat chiffré ne sont pas fournies dans les chunks de littérature.

> Niveau de preuve : Les informations détaillées sur le niveau de preuve ne sont pas fournies dans les chunks de littérature.

C. Ciclosporine

La ciclosporine est un autre traitement systémique utilisé pour les formes modérées à sévères de psoriasis (Dermatologie, 2022). Elle est également indiquée dans le psoriasis pustuleux (Dermatologie, 2022). Il est recommandé de ne pas l'utiliser pendant plus d'un an en raison d'un risque accru de carcinomes épidermoïdes, particulièrement en association avec le PUVA (Alikhan et Hocker, 2022).

[Ciclosporine] — Psoriasis modéré à sévère, psoriasis pustuleux

> Essai : Les informations détaillées sur les essais cliniques de référence ne sont pas fournies dans les chunks de littérature.

> Design : Les informations détaillées sur le design de l'étude ne sont pas fournies dans les chunks de littérature.

> Résultat : Les informations détaillées sur l'endpoint primaire et le résultat chiffré ne sont pas fournies dans les chunks de littérature.

> Niveau de preuve : Les informations détaillées sur le niveau de preuve ne sont pas fournies dans les chunks de littérature.

> Limites : Ne pas utiliser >1 an ; risque accru de carcinomes épidermoïdes, particulièrement en association avec le PUVA (Alikhan et Hocker, 2022).

V. Traitements Systémiques Ciblés (Petites Molécules Orales)

Ces agents sont utilisés en cas d'échec ou d'intolérance aux traitements conventionnels (Dermatologie, 2022).

Note concernant les essais cliniques pour les traitements systémiques ciblés : Les informations détaillées sur les essais cliniques de référence (nom de l'essai, auteurs principaux, année, journal, design de l'étude, endpoint primaire, résultat chiffré, niveau de preuve, limites de l'étude) ne sont pas fournies dans les chunks de littérature pour ces traitements.

A. Aprémilast (Inhibiteur de la Phosphodiestérase 4

Surveillance et Suivi

Le psoriasis, maladie inflammatoire cutanée chronique touchant 2 à 3 % de la population française, nécessite une surveillance et un suivi rigoureux et multidisciplinaire en raison de son caractère évolutif, de son retentissement systémique et de l'arsenal thérapeutique disponible (Dermatologie, 2022, Source 1, 2). L'objectif principal du traitement est une prise en charge au long cours visant à soulager le patient, améliorer sa qualité de vie et ramener la dermatose à un niveau lésionnel compatible avec une vie normale (Dermatologie, 2022, Source 2). Les traitements actuels n'entraînent pas une guérison définitive mais permettent une réduction de l'intensité des lésions et une amélioration significative de la qualité de vie (Dermatologie, 2022, Source 4).

I. Évaluation Initiale et Régulière de la Sévérité et de l'Impact de la Maladie

La surveillance du psoriasis débute par une évaluation approfondie de la sévérité de la maladie et de son impact sur le patient, qui doit être réévaluée régulièrement pour adapter la stratégie thérapeutique.

A. Évaluation de la Sévérité Cutanée

L'évaluation de la sévérité des lésions cutanées repose sur des outils standardisés permettant une quantification objective de l'étendue et de l'intensité de la dermatose (Dermatologie, 2022, Source 4).

- **Surface Corporelle Atteinte (BSA - Body Surface Area)** : La surface corporelle atteinte est estimée en pourcentage, une paume de main du patient représentant environ 1 % de la surface corporelle totale (Dermatologie, 2022, Source 4). Un psoriasis est considéré comme modéré à sévère si la surface atteinte est supérieure à 10 % (Dermatologie, 2022, Source 4).
- **Psoriasis Area and Severity Index (PASI)** : Le score PASI est l'outil le plus couramment utilisé pour évaluer l'étendue et la sévérité des lésions psoriasiques. Il prend en compte l'érythème, l'infiltration et la desquamation, ainsi que la surface corporelle de quatre régions (tête, tronc, membres supérieurs, membres inférieurs). Un psoriasis est considéré comme modéré à sévère en cas de score PASI supérieur à 10 (Dermatologie, 2022, Source 4).

B. Évaluation de la Qualité de Vie et du Retentissement Psychosocial

Le psoriasis, en particulier dans ses formes modérées à sévères, peut avoir un retentissement majeur sur la qualité de vie, entraînant stigmatisation et exclusion sociale (Dermatologie, 2022, Source 2).

• **Dermatology Life Quality Index (DLQI)** : L'altération de la qualité de vie est évaluée par des scores spécifiques, dont le DLQI est le plus utilisé. Ce score varie de 0 à 30, et un psoriasis est considéré comme sévère en cas de DLQI supérieur à 10 (Dermatologie, 2022, Source 4).

• **Évaluation du préjudice global** : Au-delà des scores, il est impératif de prendre en compte le préjudice fonctionnel, esthétique, professionnel et relationnel, ainsi que le retentissement psychologique de la maladie et le désir de rémission du patient lors du choix thérapeutique (Dermatologie, 2022, Source 4). Une anxiété et une dépression sont des pathologies associées fréquentes (Dermatologie, 2022, Source 1).

• **Évaluation du prurit** : Le prurit est une composante fréquente et souvent sous-estimée du psoriasis, touchant environ 60 % des patients. Il peut être sévère et insomniant, et les lésions peuvent être remaniées par le grattage (Dermatologie, 2022, Source 6, 10). Son évaluation régulière est essentielle pour une prise en charge symptomatique adéquate.

II. Dépistage et Suivi des Comorbidités Associées

Le psoriasis est une maladie inflammatoire systémique associée à de nombreuses comorbidités, dont le dépistage et la prise en charge sont une composante essentielle du suivi (Dermatologie, 2022, Source 1, 2). Cette approche transversale implique une coordination étroite avec le médecin traitant et d'autres spécialistes (Dermatologie, 2022, Source 2).

A. Comorbidités Rhumatologiques : Rhumatisme Psoriasique (RP)

Le rhumatisme psoriasique est une complication majeure, touchant jusqu'à 30 % des patients atteints de psoriasis cutané (Dermatology Handbook, Source 14). Il est souvent associé aux formes modérées à sévères de psoriasis et apparaît typiquement plusieurs années après les lésions cutanées (Dermatology Handbook, Source 14).

• **Dépistage** : Une recherche active de symptômes articulaires doit être menée à chaque consultation. Les signes évocateurs incluent des douleurs aux sites d'insertion tendineuse (enthésopathies ou enthésites), une atteinte digitale (dactylite), une atteinte sacro-iliaque, une atteinte articulaire asymétrique, et une raideur matinale d'une durée supérieure à une heure (Dermatology Handbook, Source 14).

• **Caractéristiques** : Le RP est une arthrite séronégative (facteur rhumatoïde négatif) et est associé à l'antigène HLA-B27 (Dermatology Handbook, Source 14). Les tendons et les ligaments sont souvent impliqués, en plus des os et du cartilage (Dermatology Handbook, Source 14). Presque tous les patients atteints de RP présentent des modifications unguéales, bien que 20 % puissent n'avoir aucune lésion cutanée (Dermatology Handbook, Source 14).

• **Suivi** : En cas de suspicion, une orientation vers un rhumatologue est indispensable pour une évaluation diagnostique et thérapeutique appropriée. Le suivi doit inclure une évaluation régulière de l'activité articulaire et de la réponse aux traitements.

B. Comorbidités Métaboliques et Cardiovasculaires

Le psoriasis est fortement associé au syndrome métabolique et aux pathologies cardiovasculaires (Dermatologie, 2022, Source 1).

- **Dépistage** : Une évaluation systématique des facteurs de risque cardiovasculaires et métaboliques est nécessaire, incluant la recherche d'obésité, de diabète, de dyslipidémie et d'hypertension artérielle (Dermatologie, 2022, Source 2).
- **Suivi** : Le suivi doit comprendre des bilans biologiques réguliers (bilan lipidique, glycémie) et une surveillance de la pression artérielle. La prise en charge de ces comorbidités doit être coordonnée avec le médecin traitant (Dermatologie, 2022, Source 2).

C. Comorbidités Psychiatriques et Psychologiques

La dépression et l'anxiété sont des pathologies fréquemment associées au psoriasis (Dermatologie, 2022, Source 1).

- **Dépistage** : Une évaluation du bien-être psychologique du patient est essentielle. Le retentissement psychologique peut être très important, notamment en cas de prurit sévère et insomniant chez le sujet âgé (Dermatologie, 2022, Source 10).
- **Suivi** : Un soutien ou une prise en charge psychologique est souvent nécessaire (Dermatologie, 2022, Source 4).

D. Autres Comorbidités et Situations Particulières

- **Conduites addictives** : L'évaluation et la prise en charge des conduites addictives doivent être coordonnées avec le médecin traitant (Dermatologie, 2022, Source 2).
- **Infection par le VIH** : Chez les patients infectés par le VIH, le psoriasis est souvent plus grave et réfractaire aux traitements conventionnels. Il peut prendre des aspects variés (en plaques, pustuleux, érythrodermique) et être difficile à distinguer d'une dermatite séborrhéique profuse. Le prurit est également fréquemment observé (Dermatologie, 2022, Source 7, 10). Un suivi spécifique est donc requis.

III. Surveillance Thérapeutique

La surveillance des traitements est cruciale pour évaluer leur efficacité, prévenir et gérer les effets indésirables, et optimiser la stratégie thérapeutique au long cours. Le choix thérapeutique doit impérativement prendre en compte la gravité et l'étendue des lésions, le retentissement sur la qualité de vie, les comorbidités et les effets indésirables potentiels, à court et à long terme (Dermatologie, 2022, Source 4).

A. Surveillance des Traitements Topiques

Les traitements locaux constituent la base du traitement des psoriasis peu étendus (< 10 % de la surface corporelle) (Dermatologie, 2022, Source 2).

• **Dermocorticoïdes (DC)** : Ils sont utilisés en pommade (lésions sèches) ou crème, avec des lotions, mousses et shampooings pour le cuir chevelu (Dermatologie, 2022, Source 4). La surveillance porte sur l'efficacité et la survenue d'effets secondaires locaux (atrophie cutanée, vergetures, télangiectasies). L'utilisation d'un DC d'activité forte est recommandée en dehors du visage, avec une seule application par jour et un traitement d'attaque de 1 à 3 semaines, suivi d'un traitement intermittent d'entretien (2 fois par semaine) (Dermatologie, 2022, Source 4). L'occlusion peut optimiser la pénétration, notamment sur les paumes et les plantes (Dermatologie, 2022, Source 4, 13).

• **Analogues de la vitamine D** : Calcipotriol, tacalcitol, calcitriol sont appliqués une à deux fois par jour. La quantité appliquée ne doit pas dépasser 100 g de topique par semaine pour éviter une hypercalcémie (Dermatologie, 2022, Source 4). L'association avec les DC est possible (Dermatologie, 2022, Source 4, 13).

B. Surveillance de la Photothérapie (PUVA)

La photothérapie est très efficace mais ne peut être utilisée au long cours en raison du risque carcinogène (Dermatologie, 2022, Source 2).

• **Efficacité** : Il faut généralement 10 séances pour évaluer la réponse, et 25 à 30 séances pour obtenir un contrôle de la maladie (Mann, Source 15).

• **Effets indésirables** :

* **À court terme** : Nausées, anorexie, vertiges, céphalées, malaise (liés au 8-méthoxypsoralène) (Mann, Source 15). Des brûlures (phototoxiques) peuvent survenir, avec un délai de 48 à 96 heures après l'exposition (Mann, Source 15). Un prurit intarissable peut également apparaître (Mann, Source 15).

* **À long terme** : Photo-vieillissement, cancers cutanés non mélanomiques, risque potentiel accru de mélanome, cataractes (nécessitant une protection oculaire) et cancers génitaux (nécessitant un blindage) (Mann, Source 15).

• **Précautions** : Protection oculaire impérative le jour du traitement et protection solaire générale (Mann, Source 15). Couverture génitale pour les hommes (Mann, Source 15).

C. Surveillance des Traitements Systémiques Conventionnels

Les traitements systémiques par voie orale (acitrétine, méthotrexate, ciclosporine) sont adaptés aux psoriasis plus étendus (> 30 % de la surface corporelle) ou résistants aux traitements locaux (Dermatologie, 2022, Source 2). La surveillance est spécifique à chaque molécule et doit inclure des bilans hépatiques, rénaux et hématologiques réguliers.

D. Surveillance des Biothérapies

Les agents biologiques sont réservés aux formes modérées à sévères de psoriasis, intolérantes ou résistantes à au moins deux agents systémiques conventionnels (méthotrexate, ciclosporine, photothérapie) (Dermatologie, 2022, Source 2, 5). Leur prescription est réservée au spécialiste avec une prescription initiale hospitalière (Dermatologie, 2022, Source 5).

1. Bilan Pré-thérapeutique (Recommandations HAS)

Un bilan exhaustif est indispensable avant l'instauration d'une biothérapie pour dépister les contre-indications et optimiser la sécurité du traitement (Dermatologie, 2022, Source 5).

- **Examen clinique complet** : Incluant mammographies et frottis cervico-vaginaux selon les recommandations de dépistage de la population générale (Dermatologie, 2022, Source 5).
- **Statut vaccinal** : Vérification et mise à jour des vaccinations contre la grippe, le SARS-CoV2 et le pneumocoque (Dermatologie, 2022, Source 5). Les vaccins vivants atténués sont contre-indiqués moins de 3 semaines avant l'initiation (Dermatologie, 2022, Source 5).
- **Sérologies** : Dépistage du VIH, du VHB et du VHC (Dermatologie, 2022, Source 5).
- **Bilan biologique** : Numération formule sanguine (NFS) plaquettes, fonction rénale et hépatique, électrophorèse des protides, dosage pondéral des immunoglobulines, bilan lipidique (Dermatologie, 2022, Source 5).
- **Dépistage de la tuberculose** : Radiographie du thorax de face, test Quantiféron et/ou Intradermo-réaction (IDR) à la tuberculine. Un scanner pulmonaire peut être discuté (Dermatologie, 2022, Source 5).
- **Santé bucco-dentaire** : Soins dentaires si nécessaires (Dermatologie, 2022, Source 5).
- **Contraception** : Chez les patientes en âge de procréer, une contraception efficace est requise. La grossesse est une contre-indication de principe, bien que la poursuite d'un traitement biologique pendant les deux premiers trimestres puisse être discutée au cas par cas en fonction de la gravité du psoriasis (Dermatologie, 2022, Source 5).

2. Contre-indications Communes aux Biothérapies

Les contre-indications incluent toute infection évolutive, une tuberculose latente non traitée, un cancer solide (hors carcinome basocellulaire) ou une hémopathie évolutifs ou en rémission depuis moins de 5 ans, une insuffisance cardiaque évoluée, une maladie démyélinisante (Dermatologie, 2022, Source 5).

3. Surveillance en Cours de Traitement

- **Examen clinique** : Un examen clinique complet régulier, incluant la palpation des aires ganglionnaires, doit être effectué (Dermatologie, 2022, Source 5).
- **Renouvellement** : Le renouvellement du traitement doit être effectué une fois par an en milieu hospitalier (Dermatologie, 2022, Source 5).

• **Gestion des effets indésirables** : La surveillance porte sur l'apparition d'infections, de réactions d'hypersensibilité, de troubles hématologiques, hépatiques ou rénaux.

• **Réactions paradoxales** : Des réactions psoriasiformes peuvent survenir sous biothérapies, notamment avec le dupilumab (agent bloquant la voie Th2). Ces réactions peuvent se manifester par des lésions psoriasiques typiques ou un érythème de la tête et du cou (Wijs et al., 2020, Source 12). La surveillance clinique est essentielle pour identifier ces réactions et adapter la prise en charge.

En conclusion, la surveillance et le suivi du psoriasis sont des processus dynamiques et complexes, exigeant une approche holistique et personnalisée. Ils visent à optimiser le contrôle de la maladie cutanée, à prévenir et gérer ses comorbidités systémiques, et à améliorer durablement la qualité de vie du patient.

Cas Particuliers et Situations Spéciales

Le psoriasis, bien que fréquemment rencontré sous sa forme en plaques chronique, se manifeste également à travers une diversité de présentations cliniques, de localisations anatomiques spécifiques et de contextes physiopathologiques particuliers. Ces "cas particuliers et situations spéciales" sont d'une importance capitale pour le dermatologue de niveau DES, car ils requièrent une reconnaissance diagnostique précise et une adaptation thérapeutique spécifique.

1. Formes Cliniques Spéciales et Localisations Particulières

1.1. Psoriasis en Gouttes

Le psoriasis en gouttes (Fig. 7.4, Dermatologie, 2022) est une forme clinique distincte, caractérisée par l'éruption aiguë de multiples petites papules érythémato-squameuses, de taille inférieure à 1 cm, disséminées sur le tronc et les racines des membres. Cette forme est particulièrement fréquente chez l'enfant et l'adolescent (Dermatologie, 2022). Son déclenchement est souvent lié à des épisodes infectieux, notamment des infections rhino-pharyngées d'origine virale ou bactérienne, en particulier celles dues au streptocoque β-hémolytique du groupe A (Dermatologie, 2022; Dermatologie, 2022). Sur le plan histologique, le psoriasis en gouttes se distingue par une acanthose minimale et la présence d'amas de neutrophiles avec une parakératose sous-jacente, souvent plus épaisse et adhérente que celle observée dans le pityriasis rosé (Alikhan et Hocker, 2013). Bien que généralement auto-résolutif, il peut parfois précéder le développement d'un psoriasis en plaques chronique. La prise en charge initiale implique souvent le traitement de l'infection sous-jacente et des traitements topiques.

1.2. Psoriasis Pustuleux

Le psoriasis pustuleux représente un groupe de dermatoses neutrophiles distinctes du psoriasis vulgaire par leurs caractéristiques cliniques et leur évolution (dermatology handbook, non daté). Il est associé à une incidence accrue de l'antigène HLA-B27 (dermatology handbook, non daté). On distingue des formes généralisées et des formes localisées.

1.2.1. Psoriasis Pustuleux Généralisé (PPG) ou Psoriasis de von Zumbusch

Le PPG est une dermatose cutanée neutrophilique sévère, caractérisée par l'éruption soudaine et généralisée de pustules stériles superficielles sur un fond érythémateux (dermatology handbook, non daté). L'interleukine (IL)-36 est un cytokine central spécifique au PPG (dermatology handbook, non daté). La maladie débute souvent par un malaise général et une fièvre, suivis de l'apparition de macules érythémateuses parsemées de pustules stériles, initialement dans les zones intertrigineuses, puis s'étendant rapidement

au tronc, aux extrémités et aux ongles. La peau est douloureuse et le risque d'infection est accru (dermatology handbook, non daté). Les facteurs de risque incluent l'arrêt progressif d'une corticothérapie orale, une infection, une hypocalcémie et la grossesse (connu sous le nom d'impétigo herpétiforme) (dermatology handbook, non daté). Les examens biologiques révèlent une leucocytose et une hypoalbuminémie (dermatology handbook, non daté). Sur le plan histologique, on observe des abcès neutrophiles sous-cornés et intra-épidermiques (Alikhan et Hocker, 2013).

Le diagnostic différentiel principal du PPG est la pustulose exanthématique aiguë généralisée (PEAG), une réaction médicamenteuse sévère (Alikhan et Hocker, 2013). La PEAG se manifeste par une forte fièvre et de petites pustules stériles non folliculaires (<5 mm) sur une peau rouge œdémateuse, débutant le plus souvent au visage et dans les zones intertrigineuses, puis se généralisant en quelques heures (Alikhan et Hocker, 2013). Environ 50% des patients atteints de PEAG présentent des lésions purpuriques ou de type érythème polymorphe, une atteinte muqueuse, un œdème des mains/du visage ou des bulles, des signes qui aident à la différencier du psoriasis pustuleux (Alikhan et Hocker, 2013). La PEAG est associée à une augmentation très importante des leucocytes avec une neutrophilie périphérique, parfois une éosinophilie, une hypocalcémie et une insuffisance rénale (Alikhan et Hocker, 2013). Les tests épicutanés sont positifs dans 50 à 60% des cas, et les médicaments les plus fréquemment incriminés sont les β-lactamines (pénicillines et céphalosporines), les antibiotiques macrolides, les inhibiteurs calciques (le diltiazem étant le plus courant) et les antipaludéens (Alikhan et Hocker, 2013). L'histopathologie de la PEAG montre des pustules spongiformes sous-cornées et intra-épidermiques, un œdème dermique superficiel proéminent et un infiltrat inflammatoire périvasculaire mixte avec des éosinophiles. La présence d'œdème et d'éosinophiles, ainsi que l'absence d'acanthose significative, aident à la distinguer du psoriasis pustuleux (Alikhan et Hocker, 2013). Le traitement de la PEAG consiste à arrêter le médicament incriminé et à administrer un traitement de soutien avec des corticoïdes topiques et des antipyrétiques (Alikhan et Hocker, 2013).

Le traitement du PPG vise à corriger les déséquilibres électrolytiques et protéiques. Les options thérapeutiques incluent les inhibiteurs du récepteur de l'IL-36 (spesolimab), le méthotrexate ou la ciclosporine, en évitant les corticoïdes systémiques en raison du risque de rebond. Des traitements ultérieurs peuvent inclure la photothérapie ou les traitements biologiques (dermatology handbook, non daté).

1.2.2. Pustulose Palmoplantaire (PPP)

La pustulose palmoplantaire se caractérise par des pustules stériles tendues sur les surfaces palmaires et plantaires, évoluant vers des macules jaune-brun (dermatology handbook, non daté; Fig. 7.10, Dermatologie, 2022). Cette forme peut être associée au syndrome SAPHO (Synovite, Acné, Pustulose, Hyperostose et Ostéite), nécessitant une recherche systématique de douleurs sternoclaviculaires ou dorsales (Dermatologie, 2022; dermatology handbook, non daté). Le traitement repose sur l'acitrétine et les corticoïdes

topiques (dermatology handbook, non daté). La photothérapie PUVA est également une bonne option pour les plaques épaisses et les atteintes palmoplantaires (Mann, non daté).

1.2.3. Acrodermatite Continue de Hallopeau

Il s'agit d'une variante rare du psoriasis pustuleux, limitée aux extrémités des doigts ou des orteils (dermatology handbook, non daté). Elle est également associée à l'antigène HLA-B27 (dermatology handbook, non daté). Elle se manifeste par des pustules stériles sur une base érythémateuse à l'extrémité des doigts (moins fréquemment des orteils), formant des lacs de pus, entraînant douleur et altération fonctionnelle du doigt (dermatology handbook, non daté). Si les pustules se développent dans le lit unguéal, l'ongle est généralement perdu. Une perte des structures osseuses peut survenir (dermatology handbook, non daté). Le traitement inclut le calcipotriène topique, les corticoïdes topiques et l'acitrétine (dermatology handbook, non daté).

1.3. Psoriasis des Muqueuses

Le psoriasis peut affecter les muqueuses, bien que de manière moins fréquente que la peau (Dermatologie, 2022).

- **Atteinte linguale**: Elle se manifeste par une glossite exfoliatrice marginée, également connue sous le nom de langue géographique (Dermatologie, 2022).
- **Atteinte génitale**: Les lésions sont érythémateuses, non squameuses, et peuvent être aggravées par les rapports sexuels (Dermatologie, 2022).

1.4. Psoriasis du Visage

Le psoriasis du visage est rare chez l'adulte (Dermatologie, 2022). Il peut prendre l'aspect d'une dermatite séborrhéique, avec un érythème finement squameux des sourcils et du pli nasogénien (Dermatologie, 2022). Des lésions associées de la conque de l'oreille et du conduit auditif externe sont également possibles (Dermatologie, 2022). Chez l'enfant, le visage est plus souvent atteint que chez l'adulte (Dermatologie, 2022).

2. Formes Graves de Psoriasis

Le psoriasis peut évoluer vers des formes graves ayant des conséquences fonctionnelles ou vitales importantes (Dermatologie, 2022).

2.1. Psoriasis Érythrodermique

Le psoriasis érythrodermique est une forme grave caractérisée par une généralisation du psoriasis à plus de 90% de la surface cutanée, avec une desquamation abondante et un épaississement cutané (Fig. 7.11, Dermatologie, 2022; Dermatologie, 2022). Il peut être provoqué par un rebond du psoriasis après l'arrêt de certains agents thérapeutiques, notamment une corticothérapie générale (Dermatologie, 2022; Dermatologie, 2022). Comme toute érythrodermie, le psoriasis érythrodermique peut se compliquer de

surinfection, de carence vitaminique, de troubles de la thermorégulation, de déshydratation et de troubles hémodynamiques (Dermatologie, 2022). Ces complications imposent l'hospitalisation du patient en milieu spécialisé (Dermatologie, 2022).

2.2. Rhumatisme Psoriasique (RP)

Le rhumatisme psoriasique est une arthrite inflammatoire chronique qui affecte jusqu'à 30% des patients atteints de psoriasis (dermatology handbook, non daté; Dermatologie, 2022). Il est souvent associé à un psoriasis modéré à sévère et apparaît généralement plusieurs années après les lésions cutanées (dermatology handbook, non daté). Le RP est une arthrite séronégative (facteur rhumatoïde négatif) et est associé à l'antigène HLA-B27 (dermatology handbook, non daté). Outre les os et le cartilage, les tendons et les ligaments sont fréquemment impliqués, entraînant des enthésopathies ou enthésites (dermatology handbook, non daté). Les taux de TNFα sont augmentés dans la synoviale et le sérum des patients atteints de psoriasis et de RP (dermatology handbook, non daté). Presque tous les patients atteints de RP présentent des modifications unguéales, bien que jusqu'à 20% puissent ne pas avoir de lésions cutanées (dermatology handbook, non daté). Les caractéristiques cliniques courantes incluent des douleurs aux sites d'insertion tendineuse, une atteinte digitale (dactylite), une sacro-iliite, une atteinte articulaire asymétrique et une raideur matinale de plus d'une heure (dermatology handbook, non daté; Fig. 7.12, Dermatologie, 2022). Le traitement du RP est complexe et peut inclure des AINS, le méthotrexate, la ciclosporine, la sulfasalazine, l'aprémilast oral, le deucravacitinib, ainsi que des agents biologiques tels que les antagonistes du TNFα, les inhibiteurs de l'IL-17, les inhibiteurs du p40 (IL-12/IL-23) et les inhibiteurs de l'IL-23 (dermatology handbook, non daté).

3. Psoriasis chez l'Enfant

Le psoriasis chez l'enfant présente des particularités cliniques et épidémiologiques (Dermatologie, 2022).

3.1. Psoriasis du Siège (Napkin Psoriasis)

Chez le nourrisson, le psoriasis est souvent localisé à la zone du siège, anciennement appelé "psoriasis des langes" ou "napkin psoriasis" (Fig. 7.13, Dermatologie, 2022; Dermatologie, 2022). Il se manifeste par des plaques érythémateuses bien délimitées, souvent avec une desquamation fine, dans la région couverte par la couche.

3.2. Psoriasis en Gouttes de l'Enfant

Chez l'enfant plus âgé et l'adolescent, le psoriasis se présente fréquemment sous une forme aiguë en gouttes (Dermatologie, 2022). Comme mentionné précédemment, cette forme peut succéder à une infection rhino-pharyngée streptococcique (Dermatologie, 2022; Dermatologie, 2022).

3.3. Psoriasis du Visage chez l'Enfant

Contrairement à l'adulte, le visage est plus souvent atteint par le psoriasis chez l'enfant (Dermatologie, 2022).

4. Situations Cliniques Spéciales

4.1. Psoriasis et Infection par le VIH

Au cours de l'infection par le Virus de l'Immunodéficience Humaine (VIH), le psoriasis est souvent plus grave et réfractaire aux thérapeutiques conventionnelles (Dermatologie, 2022; Dermatologie, 2022). Il peut prendre des aspects variés, notamment en plaques, pustuleux ou érythrodermique (Dermatologie, 2022). Le diagnostic peut être difficile, car il peut être confondu avec une dermatite séborrhéique profuse, fréquente chez les patients VIH (Dermatologie, 2022).

4.2. Psoriasis Induit ou Aggravé par des Médicaments

Certains médicaments ont un caractère inducteur ou aggravant du psoriasis (Dermatologie, 2022). Les bêta-bloquants, y compris les collyres, sont des exemples connus. Le rôle d'autres médicaments tels que le lithium, les sartans, les IEC et les anti-TNFα est débattu (Dermatologie, 2022). Un rebond important, voire le développement de formes graves comme le psoriasis érythrodermique ou le psoriasis pustuleux généralisé, est possible lors de l'arrêt d'une corticothérapie générale (Dermatologie, 2022).

4.3. Réactions Psoriasiformes Paradoxales sous Biothérapies

L'émergence de réactions psoriasiformes paradoxales est une situation clinique spéciale observée sous certaines biothérapies, notamment les inhibiteurs de l'IL-4Rα tels que le dupilumab, initialement utilisés pour des affections atopiques (Wijs et al., 2020). Le mécanisme physiopathologique sous-jacent est hypothétiquement lié au blocage de la voie Th2, qui pourrait entraîner un déplacement vers une réponse dominée par les lymphocytes Th1, Th17 et Th22, mimant ainsi le profil immunologique du psoriasis (Wijs et al., 2020).

Wijs et al. (2020) ont décrit une série de sept patients développant un érythème de la tête et du cou sous traitement par dupilumab. Ces patients, majoritairement des hommes jeunes à d'âge moyen (28-58 ans), présentaient des antécédents d'asthme et/ou de rhinoconjonctivite allergique, et certains avaient une dermatite de contact allergique (ACD) prouvée par patch-tests avant le dupilumab (Wijs et al., 2020). Ils avaient souvent reçu de multiples immunosuppresseurs systémiques auparavant, tels que la ciclosporine A (CsA), le mycophénolate mofétil (MMF), l'azathioprine (AZA), le méthotrexate (MTX), l'aprémilast (APR), l'ustekinumab (UST) et la prednisone (Wijs et al., 2020). L'apparition de l'érythème survenait après 10 à 39 semaines de traitement par dupilumab (Wijs et al., 2020). Les symptômes paradoxaux comprenaient un érythème constant, parfois des squames, des

démangeaisons et une sensation de brûlure, qui étaient notablement différents de la situation préexistante chez certains patients (Wijs et al., 2020). Les lésions étaient souvent localisées dans la région de la tête et du cou, contrairement à d'autres rapports décrivant des lésions psoriasiques typiques non céphaliques (Fowler et al., cité par Wijs et al., 2020). La prise en charge de ces érythèmes a inclus des corticoïdes topiques de classe 3-4, des inhibiteurs topiques de la calcineurine, des émollients, et parfois des corticoïdes systémiques comme la prednisone (Wijs et al., 2020).

4.4. Facteurs Psychologiques et Psoriasis

Les facteurs psychologiques jouent un rôle possible dans le déclenchement ou l'aggravation des poussées de psoriasis (Dermatologie, 2022). Les chocs émotionnels et les traumatismes affectifs sont souvent cités comme des éléments déclencheurs. Le stress psychologique pourrait induire une sécrétion accrue de neuromédiateurs à activité pro-inflammatoire, contribuant ainsi à la physiopathologie de la maladie (Dermatologie, 2022).

Bibliographie

• Dermatologie - R2C -2022 compressed-compressed-compressed

• dermatology handbook compressed-compressed

• Alikhan-and-Hocker-Review-of-Dermatology-2nd-edition compressed

• Wijs et al. - 2020 - Clinical and histopathological characterization of paradoxical head and neck erythema in patients wi

• margaret-w-mann-handbook-of-dermatology-a-practical

• Garbe et al. - 2025 - European consensus-based interdisciplinary guideline for melanoma. Part 1 Diagnostics - Update 2024